HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

¡Bienvenidos, buena suerte y hasta pronto!

Reunión de bienvenida y despedida de internos y practicantes

Universidad de Boyacá

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Medicina
Enfermería
Psicología
Bacteriología



ATENCIÓN EN LA SALUD MENTAL: PRÁCTICA CLÍNICA

- Edward Santiago Bobadilla Mora
- Dayana Gysella López Pineda
- Sergio Andrés Moreno Chinchilla
- Aída Yulieth Rojas Olmos
- Estefanía Velandia Malaver

PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA – UNIVERSIDAD DE BOYACÁ

CONSULTA EXTERNA - INTERCONSULTA

Evaluación psicológica

Consiste en la emisión de conceptos, psicológicos enmarcados en un proceso clínico, con el apoyo diagnóstico de herramientas de evaluación validas entrevista, cuestionarios, test, etc.



Atención psicoterapia

Asesoría, atención psicoterapéutica desde modelos terapéuticos basados en evidencia, acompañamiento psicológico, plan de tratamiento a las diferentes patologías presentadas dentro del marco de consulta externa.

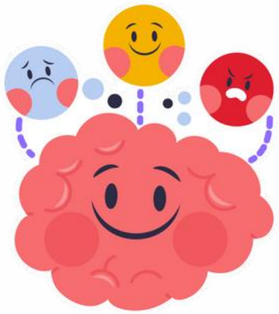


Atención a interconsulta

Proceso de solicitud de evaluación, intervención o acompañamiento, individual y familiar en los diferentes servicios del hospital regional de Moniquirá para aportar una visión específica de los procesos psicológicos observados en los pacientes.

Seguimiento intrahospitalario

Apoyo emocional a los pacientes y sus familiares, que se encuentren hospitalizados.



SEMANA ANDINA: GESTIÓN DEL ESTRÉS





PREVENCIÓN DEL SUICIDIO







IAMII



FESTIVAL DE LA SALUD MENTAL







GRUPO: PAUTAS DE CRIANZA

conectando desde la consciensa, el respeto y la empatia.

MODULO 1. NEUROEDUCACION

- EL CEREBRO EN DESARROLLO. PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO
- CEREBRAL 0-18 AÑOS.

MODULO 2. FUNDAMENTOS DE LA CRIANZA CONCIENTE

- ¿QUÉ ES LA CRIANZA CONSCIENTE?
- FUNDAMENTOS DE LA CRIANZA CONSCIENTE (KABAT-

MODULO 3. REDUCCION DE LA CONDUCTA AUTOMATICA.

- Modelo de Dumas: Automatismo y Consciencia.
- Estrategias para romper la automaticidad.

MODULO 4. DIMENCIONES DE MINDFULNESS EN LA CRIANZA.

- MINDFULNESS EN LA CRIANZA.
- REDIRIGIR.



MODULO 5. DEFINIR VALORES EN LA CRIANZA.

- DEFUSION COGNITIVA
- CRIAR DESDE MIS VALORES



PROCESO DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON ACT: CASO M.A.R.H



Datos sociodemográficos

Nombre: M.A.R.H
Edad: 16 años
Sexo: Masculino
Residencia: Vereda Maciegal, Moniquirá
Escolaridad: Décimo grado
Estado civil: Soltero
Núcleo familiar: Vive con madre y abuela materna

Evaluación diagnóstica

Objetivo de la evaluación:

- Valorar rigidez psicológica, evitación experiencial y presencia/resultados de sintomatología depresiva.

Instrumentos utilizados:

- AAQ-II: mide evitación experiencial e inflexibilidad psicológica.
- CDI-2: identifica síntomas depresivos en adolescentes

Diagnóstico

- Trastorno mixto de ansiedad y depresión (F41.2, DSM-5)

Desde ACT se describen procesos relevantes:

- Alta evitación experiencial
- Fusión cognitiva con autocrítica
- Baja acción comprometida

Motivo de Consulta

Remitido por neuropediatría para evaluación psicológica integral.
Razones principales:

- Alteraciones del sueño
- Antecedentes neurológicos
- Síntomas emocionales: ansiedad y tristeza



Antecedentes

Personales y Psicosociales

- Historia de matoneo relacionado con dificultades motoras y del habla, lo cual generó inseguridad, retraimiento y autopercepción negativa.
- Red de apoyo sólida: madre y abuela, con predominio estilo sobreprotector.

Persisten:

- Ansiedad anticipatoria por rendimiento escolar
- Temor a la crítica
- Tendencia a evitación experiencial

Médicos

- Prematurez extrema (26 semanas) y derrame grado IV.
- Apnea del sueño y dificultades actuales para dormir.
- Cirugías por pie equino (limitación motora inicial).
- Trastorno del habla con tratamiento fonoaudiológico.

Psiquiátricos

- Diagnóstico previo: Trastorno mixto de ansiedad y depresión.
- Tratamiento: fluoxetina y trazodona (respuesta parcial).
- Persisten preocupaciones, autocrítica y problemas de sueño.

Terapia de Aceptación y Compromiso

Se enfoca en cambiar la relación con pensamientos y emociones, no en eliminarlos.

La evitación experiencial es un proceso psicológico donde una persona intenta evitar, controlar o escapar de sus pensamientos, emociones, recuerdos o sensaciones internas porque le resultan incómodas o dolorosas.

1. **Aceptación** de experiencias internas.
2. **Defusión cognitiva:** observar pensamientos sin fusionarse con ellos.
3. **Contacto con el momento presente.**
4. **Yo como contexto:** perspectiva del observador.
5. **Clarificación de valores**.
6. **Acción comprometida** coherente con los valores.

Limitaciones



- Alta demanda del servicio que dificultó el agendamiento y generó sesiones irregulares.
- Baja disponibilidad del paciente por múltiples controles médicos y terapéuticos, lo que ocasionó reprogramaciones e interrupciones en el proceso.
- Contexto académico complejo: ausencias frecuentes, rezago escolar, incremento de la carga académica y mayor ansiedad por rendimiento.
- Coincidencias entre actividades escolares y las citas psicológicas, afectando la asistencia continua.

PROCESO DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON TCC: CASO C.A.N



Datos sociodemográficos

- Nombre: Paciente
- Edad: 11 años
- Sexo: Masculino
- Lugar de residencia: Moniquirá, Boyacá
- Escolaridad: 6° grado (actualmente retirado del colegio)
- Estructura familiar: Padres separados; vive con su padre
- Actividades recreativas: Taekwondo y ciclismo
- Dinámica social: Se comunica con compañeros, pero no logra formar amistades cercanas

Motivo de consulta

El padre consulta por dificultades socioemocionales del menor, como baja motivación, ánimo decaído, poca socialización y escasa regulación emocional. En la entrevista, el niño se muestra de comunicación limitada, con voz tenue pero colaborador. Refiere experiencias escolares negativas, incluido acoso escolar y un cambio de institución que describe como un entorno restrictivo y poco acogedor.

Evaluación diagnóstica

Vanderbilt (padres): síntomas de TDAH, comorbilidades, rendimiento escolar

Children's Depression Inventory (CDI): afectividad, autoconcepto, tristeza, culpa



Resultados de evaluación

Área evaluada	Hallazgos principales
Atención (Vanderbilt)	Inatención moderada; se distrae con facilid dificultades para mantener el foco y compl tareas; desorganización frecuente.
Hiperactividad / Impulsividad (Vanderbilt)	Inquietud motora elevada, interrupciones constantes, dificultad para esperar turnos y controlar impulsos.
Conducta Oposicional	Irritabilidad y discusiones ocasionales; resist leve a normas; conductas reactivas más qu desafiantes.
Área Emocional (CDI)	Tristeza leve, inseguridad, autocrítica y culp vulnerabilidad emocional; sin ideación suici
Relaciones Sociales	Dificultad para formar amistades cercanas; retraimiento; baja expresividad emocional; preferencia por actividades solitarias.
	Dificultades en lectura, escritura y matemát

Diagnóstico

Diagnóstico principal:

- Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), tipo combinado. (F90.2 según CIE-10; 314.01 según DSM-5-TR)

Análisis Funcional

Antecedentes

- Correcciones constantes
- Transiciones o cambios inesperados
- Experiencias de acoso escolar previas
- Inseguridad al interactuar con pares



Conductas

- Distracción
- Impulsividad
- Retraimiento emocional
- Aislamiento social
- Conflictos leves

Consecuencias

- Evita situaciones estresantes
- Reduce ansiedad evitando tareas difíciles
- Recibe atención correctiva (involuntaria)
- Se mantiene la dinámica de evitación y retraimiento

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

¿Qué es?

La Terapia Cognitivo-Conductual es un enfoque psicoterapéutico basado en la idea de que los pensamientos, las emociones y las conductas están interrelacionados. Su objetivo es identificar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales para producir cambios en las emociones y en el comportamiento.



Plan de tratamiento

Área	Objetivo
Psicoeducación	Comprender el TDAH y regular conductas.
Funciones ejecutivas	Mejorar atención y organización.
Regulación emocional	Manejar frustración y ansiedad.
Impulsividad	Incrementar autocontrol.
Cogniciones	Reducir autocrítica e inseguridad.
Habilidades sociales	Mejorar interacción con pares.
Familia	Fortalecer convivencia y normas.
Escuela	Favorecer el rendimiento y la adaptación académico.



ABORDAJE CLÍNICO DE PSICOLOGÍA DESDE TERAPIA DE ACEPTACIÓ Y COMPROMISO (ACT) PACIENTE N.O

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

EDAD: 30 AÑOS
ESCOLARIDAD: PREGRADO
SEXO: MASCULINO
OCUPACIÓN: DOCENTE
RESIDENCIA: MONIQUIRA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
NÚCLEO FAMILIAR: UNIPERSONAL



DIAGNÓSTICO



- DIAGNÓSTICO Trastorno mixto de ansiedad y depresión (F41.2, DSM-5)

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente con orden de manejo ambulatorio para iniciar porceso psicoterapeutico posterior a atención en el servicio de urgencias del hospital de moniquira.

Motivos principales:

- Ideación suicida (carta)
- estado de ánimo deprimido y ansioso.

ANTECEDENTES

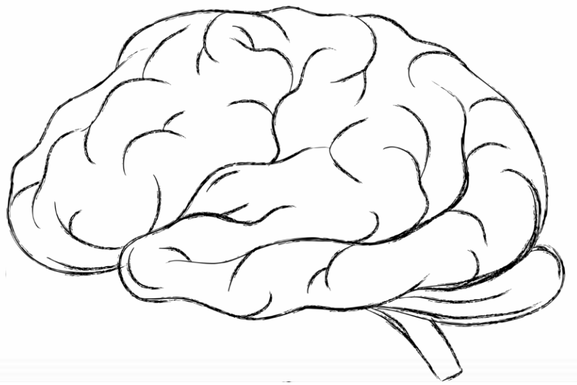
ANTECEDENTES MÉDICOS

- Esguince y distensión del ligamento colateral medial (tibial).
- Alteración en el sueño (insomnio)

ANTECEDENTES PSIQUÍATRICOS

- Trastorno mixto de ansiedad y depresión.
- Tratamiento: melatonina

ANTECEDENTES PERSONALES Y PSICOLÓGICOS



- Antecedentes de estilo de crianza autoritario, caracterizado por baja expresión afectiva y alta exigencia por parte de progenitores.
- Presencia de pensamientos de minusvalía y autopercepción deteriorada.
- Tendencia a la comparación constante con su hermana mayor, fallecida hace ocho años.
- Dificultad para identificar y experimentar actividades o experiencias gratificantes.

TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO

- Aceptación: permitir y experimentar emociones, sensaciones y pensamientos difíciles sin intentar evitarlos
- Defusión cognitiva – Separar pensamientos de realidad.
- Momento presente – Atención plena al ahora.
- Yo como contexto – Ser observador interno.
- Valores – Principios personales significativos.
- Acción comprometida – Actuar según valores.

SESIONES REALIZADAS

Contextualización inicial

- Revisión del motivo de consulta y expectativas.
- Explicación del modelo ACT y del proceso de intervención.

Historia personal y vínculo terapéutico

- Identificación inicial de valores y áreas de malestar.

Conciencia plena y autorregulación emocional

- Introducción al Mindfulness.
- Reconocimiento de pensamientos automáticos.

Regulación emocional mediante Mindfulness

- Prácticas guiadas.
- Reducción de rumiación y mayor contacto con el presente.

Acción comprometida y valores personales

- Identificación de valores centrales.
- Diseño de acciones pequeñas y viables alineadas con dichos valores.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS

CUESTIONARIO BIOGRÁFICO AUTOAPLICADO

- Instrumento destinado a explorar historia personal y dinámica familiar.
- Resultado: Se observó poca disposición para profundizar en aspectos familiares y respuestas limitadas.

METÁFORA DEL JARDÍN

- Técnica utilizada para identificación y clarificación de valores personales.
- Resultado: Se identificó dificultad para reconocer valores y elementos significativos en su vida.

LIMITACIONES

Dentro de las limitaciones que dificultaron la continuidad del proceso psicoterapéutico, se identificó una baja disposición del paciente y un escaso interés en aplicar de manera práctica los contenidos trabajados en cada sesión.



EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CLÍNICA. CASO H.A.

Datos sociodemográficos



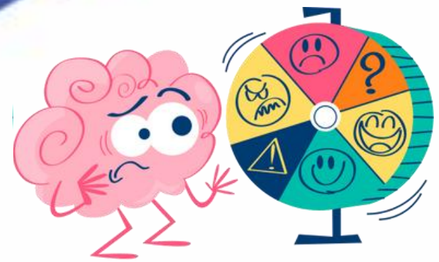
Paciente: H.A.
Sexo: femenino
Edad: 41 años
Vida laboral: Ama de casa
Educación: bachiller
Contexto familiar: familia nuclear funcional. Relación conflictiva con familia extensa.
Tratamientos anteriores: ninguno por psicología. Psiquiatría con manejo farmacológico,
Desistimiento debido a accidente de tránsito ocasionado por somnolencia (dosis adicional del medicamento).

Motivo de consulta

Paciente refiere: “fui a medico general, porque me duele mucho la cabeza, no ha podido dormir, ganas de llorar, irritabilidad”.

Diagnóstico

F412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION



Sintomatología

Ansiedad
Preocupaciones excesivas, tensión constante, incapacidad para relajarse.

Depresión
Desesperanza, llanto fácil, irritabilidad, baja autoestima, sensación de falta de control.

Fobias o temores:
Miedo a su sintomatología.

Evaluación

- Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) (Beck et al., 1988; Beck y Steer, 1993).
- Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) (Beck, Steer y Brown, 1996).
- Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberger et al., 1982; adaptada por Ballesteros, 2013).
- Escala de Autocuidado de González-Vázquez et al. (2018).

Resultados

Instrumento	Interpretación
STAI — Rasgo	Alto
STAI — Estado	Moderado
BAI (Beck, ansiedad)	Moderada
BDI-II (Becks,	Depresión severa
Escala de Autocuidado	Bajo



Objetivo terapéutico

Promover el desarrollo de flexibilidad psicológica en la paciente H, como estrategia terapéutica para el abordaje de su sintomatología ansioso-depresiva.

Tratamiento

Plan de tratamiento basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), junto con intervenciones enfocadas en la regulación emocional, en la modificación de patrones de autocuidado, la flexibilidad psicológica y la construcción de conductas guiadas por valores.

Evolución del proceso

Sesión 1: historia clínica
Sesión 2: Contención emocional. Entrenamiento en ejercicio de atención plena.
Sesión 3: Evaluación (pruebas psicométricas).
Sesión 4: Psicoeducación en ACT.



Limitaciones

- Disponibilidad de agenda.
- Elevada reactividad emocional.
- Bajo nivel de autocuidado.
- Dificultad para solicitar y aceptar apoyo.

CASO DE LA PACIENTE “ANA R.”

¿QUÉ ENFOQUE SE USO?

Se utilizó la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), ya que promueve un aumento en la flexibilidad psicológica de la paciente, lo cual se reflejaría en una mejora del bienestar emocional, del funcionamiento social y, en general, de su calidad de vida.

Fases de la intervención

CONTEXTUALIZACIÓN

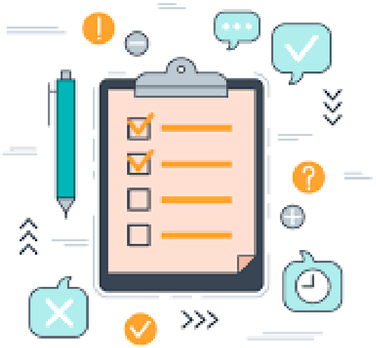
Esta se llevó a cabo a partir de la creación de la historia clínica mediante una entrevista semiestructurada.





Paciente femenina de 65 años. La paciente refiere presentar episodios de ansiedad acompañados de sensación de intranquilidad, tensión física principalmente en el cuello, hombros y espalda, así como preocupación constante ante diferentes situaciones de su vida cotidiana, especialmente en contextos sociales donde debe interactuar con otras personas.

EVALUACIÓN.



Esta se llevó a cabo por medio de instrumentos de carácter cualitativo y cuantitativo.



La Escala de Autocuidado y el Cuestionario Autobiográfico son de carácter cualitativo, brindando información primordial sobre la paciente y su entorno.



En los instrumentos cuantitativos se encuentran el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), con puntajes de E24 y R23, los cuales se consideran bajos; el AAQ-II, con un puntaje de 26, que indica una flexibilidad psicológica media; y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), con un puntaje de 32, lo cual corresponde a ansiedad severa.



Los resultados de estos instrumentos permiten inferir que la paciente presenta síntomas asociados a un trastorno mixto de ansiedad y depresión (6A7Z).



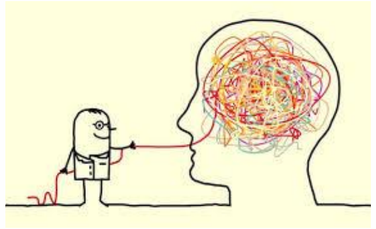
VENTANA DE TOLERANCIA.

Se realiza psicoeducación referente a la ventana de tolerancia, así como a los conceptos de hiperactivación e hipoactivación.



RECONOCIMIENTO DE VALORES PERSONALES.

Para generar la identificación de valores personales, se utilizó el Cuestionario de Valores Personales.



DEFUSIÓN COGNITIVA.

Esta se llevará a cabo por medio de la metáfora del otoño, la cual busca tomar distancia de los pensamientos, restándoles control, con el fin de poder vivir de manera más acorde con los valores personales.

ACEPTACIÓN EMOCIONAL.



Según la ACT, consiste en abrirse a las emociones y pensamientos sin evitarlos, para poder actuar en coherencia con los valores personales.



PLAN DE CONTINUIDAD Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se establece a través de la enseñanza de ejercicios de mindfulness. Por otra parte, la medición de los avances terapéuticos se realizará por medio de los instrumentos previamente utilizados en la fase de evaluación.

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE

GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO

GINE ALEJANDRA GONZALEZ CASAS
KAREN DAYANA PULIDO LEÓN

Universidad de Boyacá

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E

CALIDAD: Conjunto de acciones que garantizan que los resultados emitidos sean confiables, exactos y oportunos para la toma de decisiones clínicas.

¿Cómo garantizamos la calidad?

FASE PRE-ANALÍTICA

- Identificación correcta del paciente.
- Preparación adecuada (ayuno, horarios).
- Transporte y conservación adecuados.

FASE ANALÍTICA

- Mantenimiento de equipos.
- Uso adecuado de reactivos y controles.
- **Control de calidad interno y externo.**

FASE POST-ANALÍTICA

- Entrega oportuna e interpretación adecuada.
- Informe claro, sin errores.
- Corrección de resultados críticos.

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E

Universidad de Boyacá

CONTROL DE CALIDAD INTERNO

Frecuencia de corridas

Gráficas de Levey–Jennings

Procedimientos que permiten monitorizar el proceso analítico garantizando su calidad y confiabilidad.

Materiales de control

Reglas de Westgard



ATCC®

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO

Determinación del desempeño de los procedimientos analíticos del laboratorio, mediante la comparación entre diferentes laboratorios.

Verificar la exactitud de los métodos analíticos.

Identificar errores no detectados por el control interno.

Comparar el desempeño del laboratorio con otros centros.

Proveedor externo.

Muestras desconocidas.

Recepción de informe de desempeño.

RIQAS

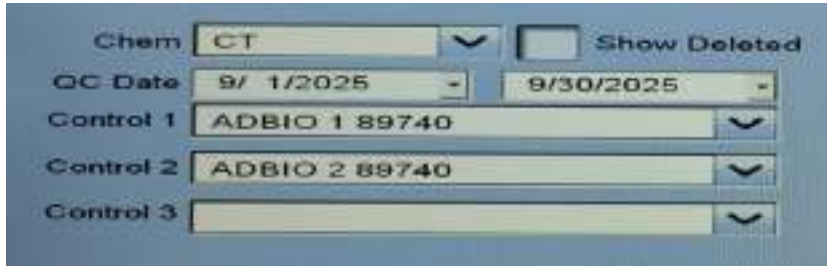
Proasecal®

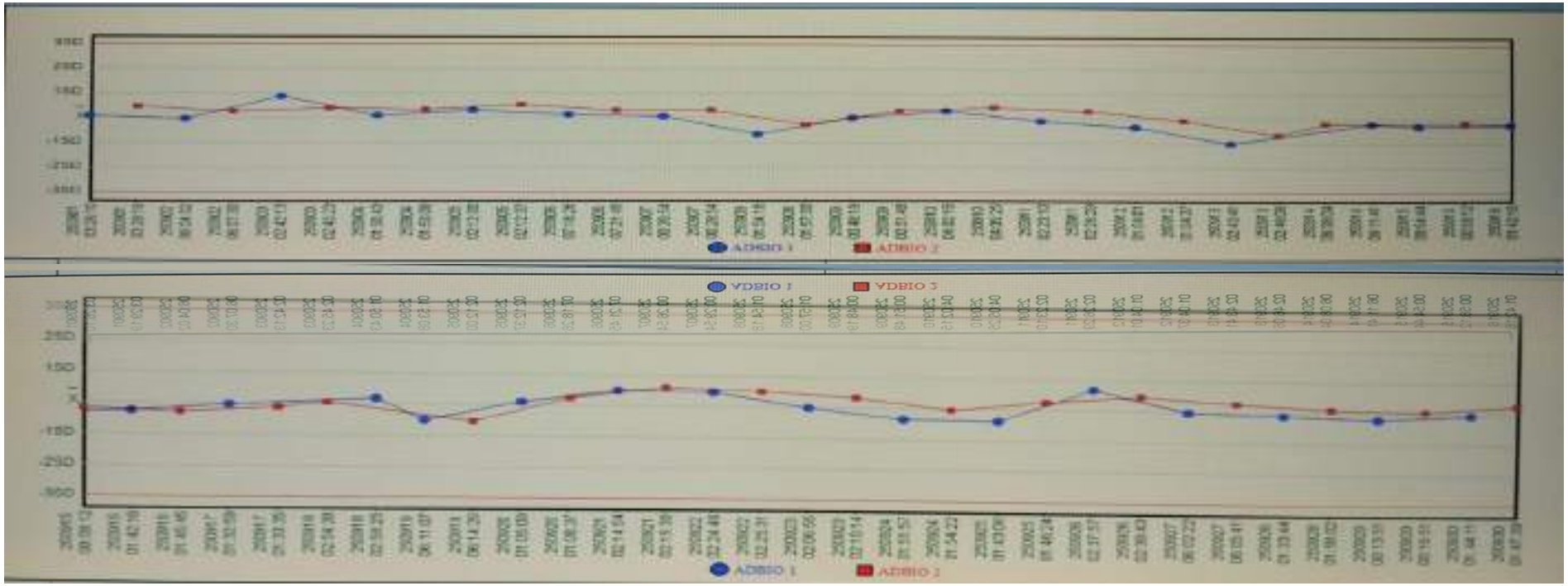
American Proficiency Institute

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E

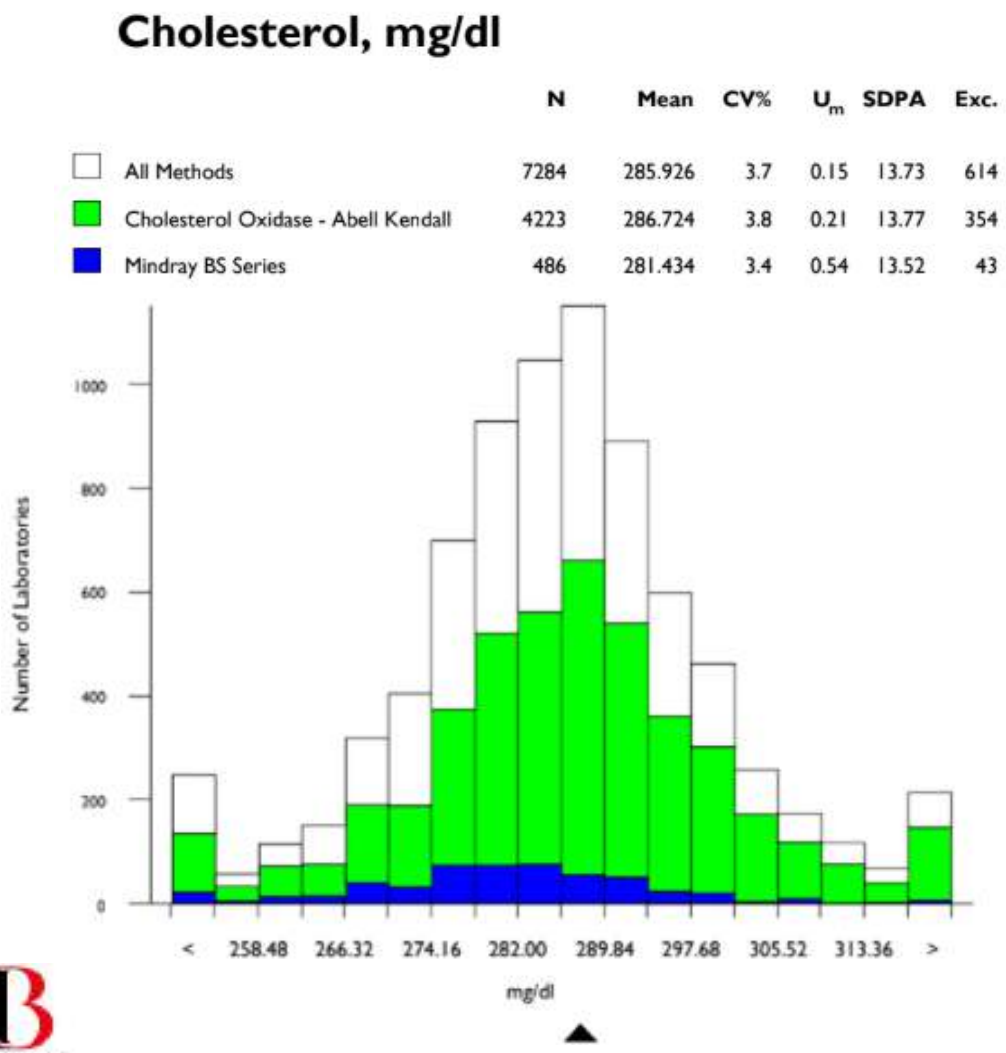
Universidad de Boyacá

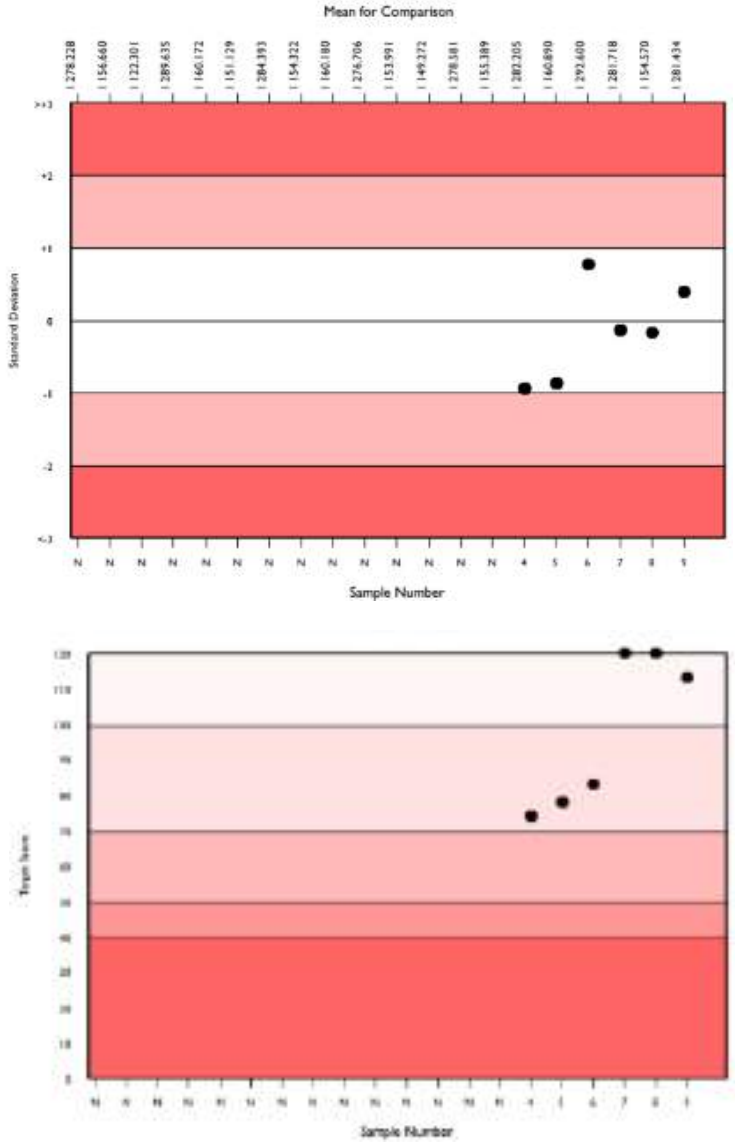
CONTROL DE CALIDAD INTERNO





CONTROL DE CALIDAD EXTERNO





¡GRACIAS!

Universidad de Boyacá

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E

"UN CAMINO DE APRENDIZAJE, SERVICIO Y HUMANISMO DURANTE EL INTERNADO, HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ."

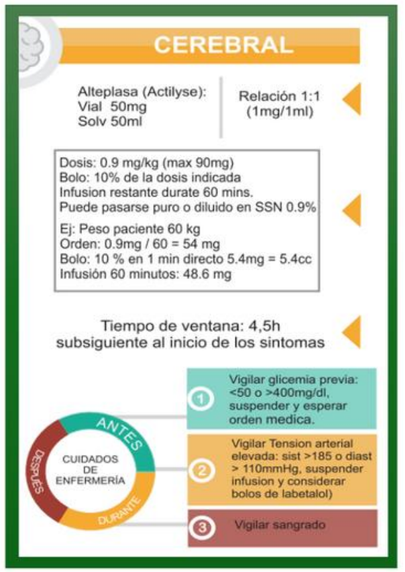
- DIEGO ALEXANDER CHAPARRO
- LIZBETH KARELLY CARRILLO HERNÁNDEZ
- CRISTIAN FABIAN PATIÑO BARRIOS
- MARIA PAULA GARCÉS
- LUISA FERNANDA BAUTISTA REYES

INTERNOS DE ENFERMERÍA-UNIVERSIDAD DE BOYACÁ

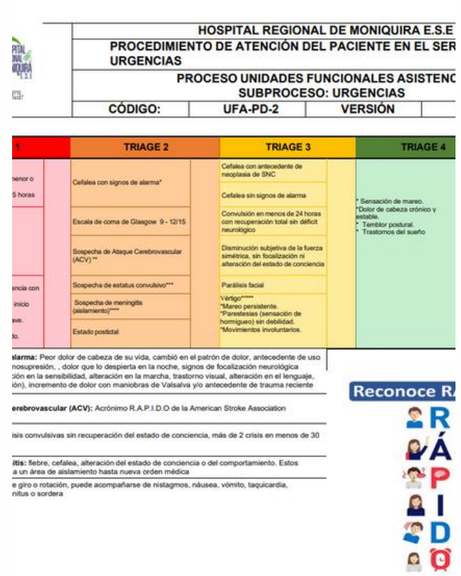


URGENCIAS

- "**ATENCIÓN RÁPIDA, CEREBRO A SALVO:** SOCIALIZACIÓN DEL MANEJO DEL ATAQUE CEREBROVASCULAR (ACV) EN URGENCIAS“
- ENTREGABLE PORTA CARNET ACV.
- **PRIORIDAD EN URGENCIAS:** LA HIGIENE DE MANOS, CLAVE PARA TODOS (JUEGO DIDÁCTICO ENTREGABLE)
- ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO TRIAGE
- PROTOCOLO ADMINISTRACION SEGURA DE SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL
- TABLERO IDENTIFICACIÓN SEGURIDAD DEL PACIENTE(ENTREGABLE).





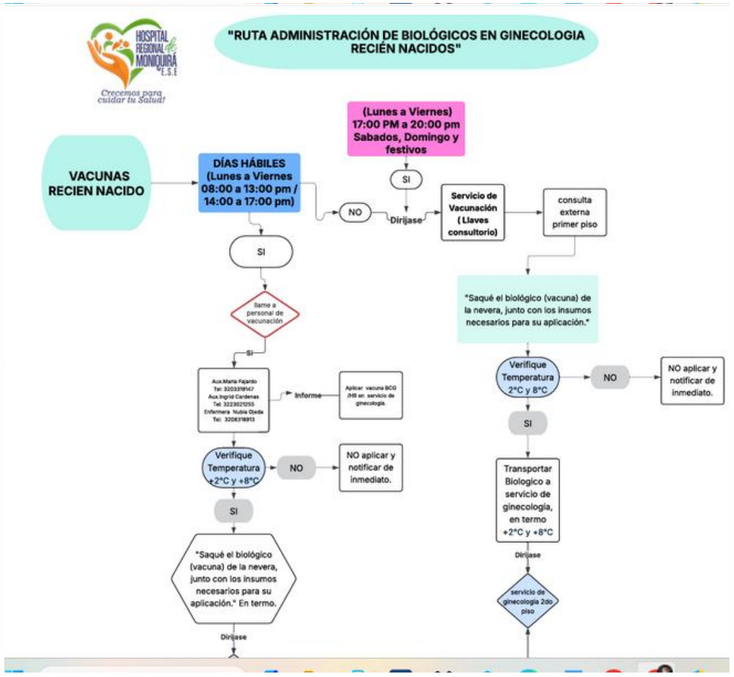


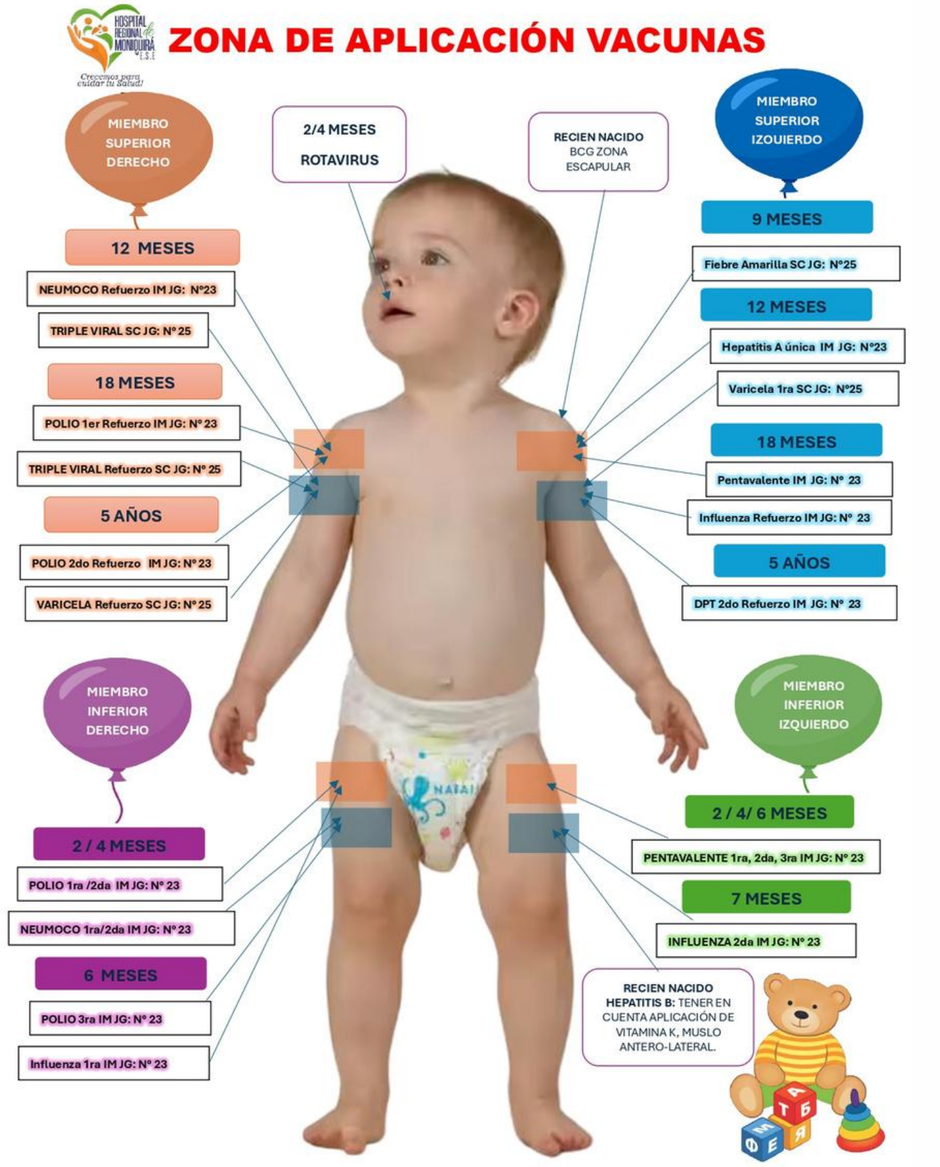


DIEGO ALEXANDER CHAPARRO, INTERNO DE ENFERMERIA .

CONSULTA EXTERNA

- ENTREGABLE (SITIOS DE APLICACIÓN VACUNAS)
- FORMATO, ENCUESTA PREVACUNAL ESQUEMA ATRASADO
- FORMATO ENCUESTA PREVACUNAL PARA NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS
- RUTA ADMINISTRACIÓN DE BIOLÓGICOS RECIÉN NACIDOS.
- LIDERAZGO JORNADA DE VACUNACIÓN EXTRAMURAL: COLEGIOS, JAIRO ANIBAL, SEDE CENTRAL, AGRICOLA.





DIEGO ALEXANDER CHAPARRO, INTERNO DE ENFERMERIA .

CONSULTA EXTERNA



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

ENCUESTA PREVACUNAL PARA NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

FORMATO DE CONTROL ENCUESTA PREVACUNAL
PROCESO: SEGURIDAD DEL PACIENTE
SUBPROCESO: PAI
Código: Versión

Municipio _____ **IPS vacunadora** _____

Pídale al usuario al que va a vacunar contra las vacunas de 0 a 5 años que por favor responda las siguientes preguntas antes de proceder a su vacunación

Fecha	Nombres y apellidos	¿Tiene alguna enfermedad que le baja las defensas (por ejemplo, cáncer, leucemia, linforma SIDA, diabetes, etc.)?		¿Utiliza medicamentos que le bajen las defensas como por ejemplo corticoides?		¿Tiene alguna otra enfermedad crónica como por ejemplo enfermedades del timo, higado, corazón, riñón, etc?		¿Ha presentado reacciones graves, como desmayo o dificultad para respirar despues de consumir huevos de gallina, mani, fresas?		¿Ha presentado fiebre en las últimas 48 horas?		¿El niño/a ha recibido alguna vacuna en los últimos 30 dias?		¿Ha tenido alguna reacción alérgica grave a vacunas anteriores?		¿Está tomando algún medicamento actualmente?		¿Ha tenido convulsiones o fiebre con convulsiones?		¿Tiene el niño/a tos, resfriado, diarrea o algún otro síntoma de enfermedad?		¿Apto para vacunación hoy? TENER EN CUENTA: si respondió negativamente todas las preguntas VACUNAR /Si respondió positivamente a una o más preguntas, la persona requiere de valoración médica antes de ser vacunado			FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	OBSERVACIONES	

OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE

DIEGO ALEXANDER CHAPARRO, INTERNO DE ENFERMERIA .

CONSULTA EXTERNA-GINECOLOGÍA

- ASISTENCIA Y APOYO EN LA SEMANA ANDINA, CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS AMIGABLES Y ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN.
- SOCIALIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
- DESARROLLO DE CHARLA EDUCATIVA Y ENTREGA DE FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH).
- LIDERAZGO Y APOYO ACTIVO EN JORNADAS EXTRAMURALES Y CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.
- ANÁLISIS INTEGRAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN, CON ENFOQUE EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL USUARIO.

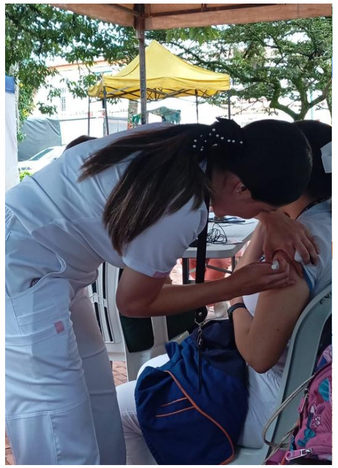










LIZBETH KARELLY CARRILLO HERNÁNDEZ, INTERNA DE ENFERMERIA.

CONSULTA EXTERNA-GINECOLOGÍA



- FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN ESQUEMAS DE VACUNACIÓN PARA GESTANTES Y POBLACIÓN INFANTIL, GARANTIZANDO ACTUALIZACIÓN EN LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES.
- SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES INFORMATIVOS RELACIONADOS CON LA RUTA MATERNO-PERINATAL.
- PRESENCIA ACTIVA EN STAND ORIENTADO A PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
- PARTICIPACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES DE NOVIEMBRE, FORTALECIENDO LOS PROCESOS DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA.

LIZBETH KARELLY CARRILLO HERNÁNDEZ, INTERNA DE ENFERMERIA.

CONSULTA EXTERNA-GINECOLOGÍA

























LIZBETH KARELLY CARRILLO HERNÁNDEZ, INTERNA DE ENFERMERIA.

GINECOLOGÍA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

- SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS EN EL COMITÉ PRIMARIO DE GINECOLOGÍA“
- PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE HABILIDADES EN LACTANCIA MATERNA DESARROLLADA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.
- APOYO EN EL PRIMER TALLER DE ACCESOS VASCULARES ORGANIZADO POR EL GRUPO DE TERAPIA INTRAVENOSA.
- ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN SEGURA DE SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL.
- PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SEMANA ANDINA DÍA DEL SUEÑO REPARADOR.
- ASISTENCIA EN CAPACITACIÓN CÓDIGO TRAUMA DIRIGIDA POR EL URGENCIÓLOGO DR. IVÁN ORTIZ.



CRISTIAN FABIAN PATIÑO, INTERNO DE ENFERMERIA .

GINECOLOGÍA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

- ENTREGABLE EDUCACTIVO DE ATAQUE CEREBROVACULAR ISQUÉMICO PARA 5 SERVICIOS DEL HOSPITAL.

- SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO PARA REDUCIR RIESGO DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO.







CRISTIAN FABIAN PATIÑO, INTERNO DE ENFERMERIA .

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS





* PROPUESTA DE COMPARENDOS PEDAGÓGICOS.

* CLUB DE REVISTA: EXPERIENCIA DE UN GRUPO DE PACIENTES CON LA ALIMENTACIÓN RECIBIDA DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA EN EL AÑO 2025.

* APOYO EN LA PREPARACIÓN Y CONEXIÓN DE PACIENTES PARA DIÁLISIS.

*CURACIÓN DE ACCESOS VASCULARES CENTRALES

* LISTAS DE CHEQUEO REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO.

* LISTA DE CHEQUEO BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE IASS SOCIADAS A DISPOSITIVOS

MARIA PAULA GARCÉS, INTERNA DE ENFERMERIA .

HOSPITALIZACIÓN





* ACTUALIZACIÓN DE NOTAS DE ENFERMERÍA

* ACTUALIZACIÓN DE PROCOLO DE ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS

* PRESENTACIÓN DEL MANEJO CORRECTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

* PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE LA SALUD MENTAL 2025

*LISTA DE CHEQUEO ADHERENCIA AL LAVADO E HIGIENE DE MANOS

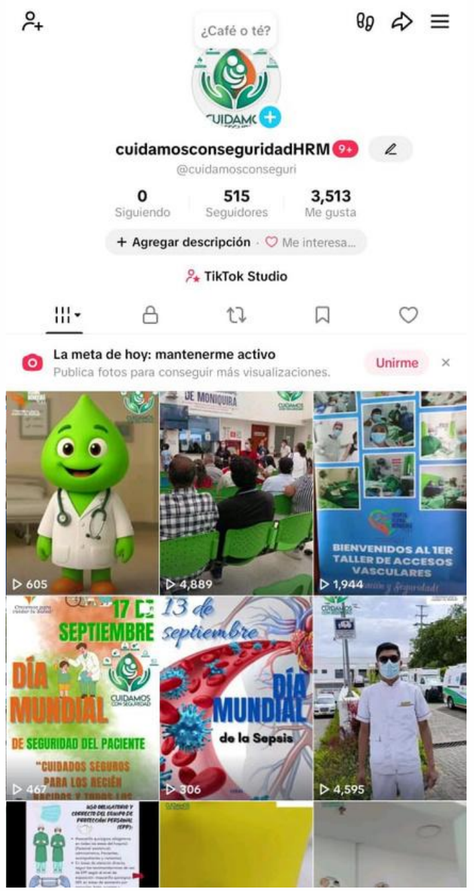
MARIA PAULA GARCÉS, INTERNA DE ENFERMERIA .

COORDINACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

- ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CAMAS.
- ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMAS.
- ACTUALIZAR Y REVISAR EL PROTOCOLO DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL.
- ACTUALIZAR Y REVISAR EL PROTOCOLO DE VARIABLES CRÍTICAS.
- REVISAR Y FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE ROPA HOSPITALARIA.
- ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DE INVENTARIO DE HABITACIÓN.
- ACTUALIZAR LA CIRCULAR DEL PLAN DE CONTINGENCIA.
- CREAR UNA CIRCULAR PARA ESTABLECER LAS DISPOSICIONES PARA CAMBIOS DE TURNOS.
- ELABORAR CUADRO DE TURNOS INTERNOS DE ENFERMERÍA.







LUISA FERNANDA BAUTISTA REYES

COORDINACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

-ACTA DE LAVADO DE MANOS Y ACOMPAÑAMIENTO POR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR EDUCACIÓN DE LAVADO E HIGIENE DE MANOS

-CREAR CARTILLA PARA MODIFICAR LOS LETREROS DE AISLAMIENTO A UNOS MÁS PRÁCTICOS

-REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

-CREAR PÁGINA DE TIK TOK

-REALIZAR ACTIVIDAD DE SEMANA HIGIENE DE MANOS: CADA DÍA SE SUBÍA UN VÍDEO DE UN SERVICIO DIFERENTE.

-REALIZAR VIDEOS EDUCATIVOS E INFOGRAFÍAS PARA LAS REDES SOCIALES

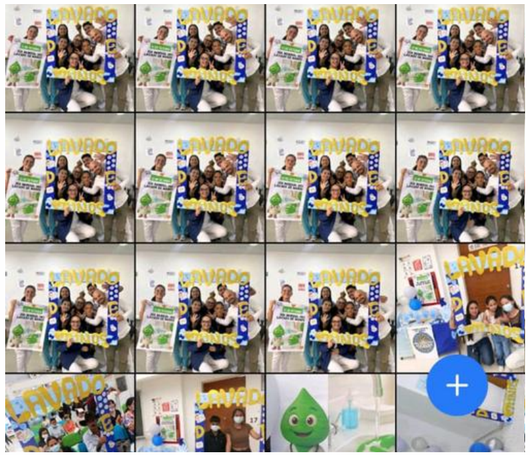
-CREAR PLANTILLA PARA CERTIFICADOS

-ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE- MES DE SEGUIRDAD DEL PACIENTE CON CAPSULAS DIARIAS EDUCATIVAS , SEMANA ANDINA, SEMANA DE VIDA SALUDABLE.-ENFOQUE MASTERCHEF SALUDABLE,ZUMBA EN MANEJO DEL ESTRÉS.

-DIA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS DONDE SE DIO A CONOCER A LOS PACIENTES Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL LA MASCOTA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.



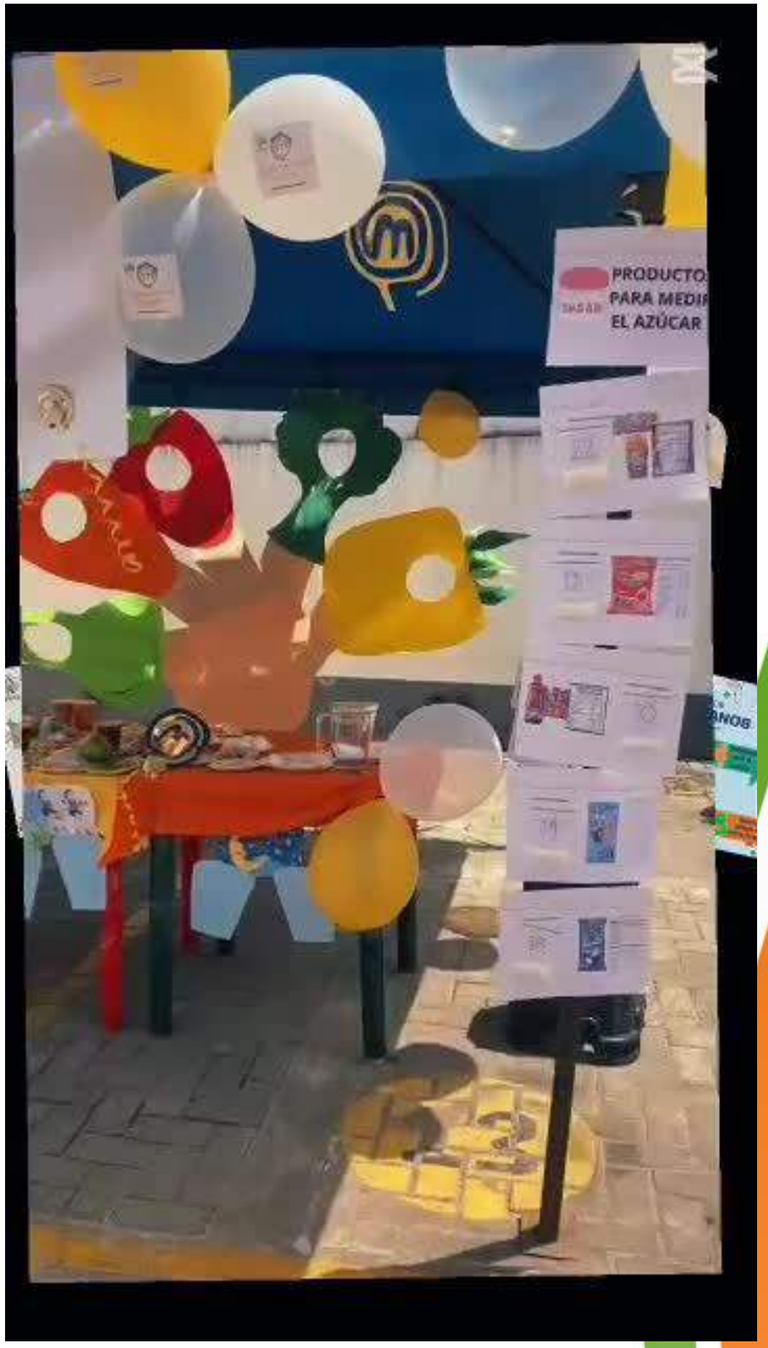




LUISA FERNANDA BAUTISTA REYES

COORDINACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

LUISA FERNANDA BAUTISTA REYES



HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Estrategias de Impacto: aporte de los médicos internos al cuidado, prevención, eficiencia y excelencia en el **Hospital Regional de Moniquirá**



Médicos Internos Cohorte 2025 - 2

Cirugía general: investigación, difusión e innovación



Day en salas de cirugia, su hábitat natural



Dayra Muñoz Huertas
UPTC

Cirugía General



Reportecaso clínico

INTUSUSCEPCIÓN Y VOLVULACIÓN SECUNDARIA A TUMOR NEUROENDOCRINO DE LA VÁLVULA ILEOCECAL, REPORTE DE CASO

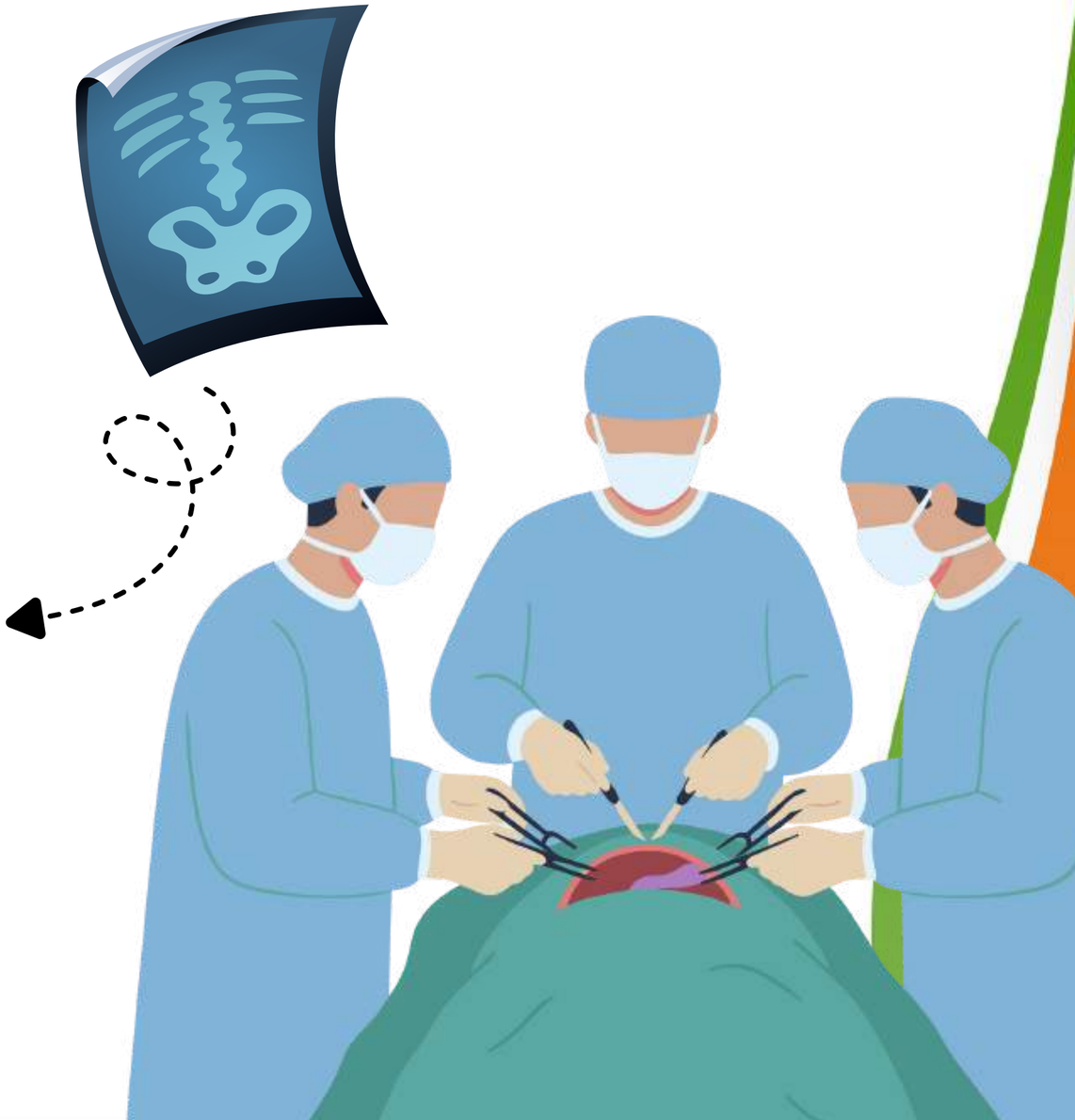
INTRODUCCIÓN

Los tumores neuroendocrinos (NET) de localización ileocecal son entidades infrecuentes y habitualmente se diagnostican en estadios avanzados. Reportes de prevalencia estimada de 3.5 - 4.5 casos por cada 100.000 habitantes. Su presentación clínica puede ser inespecífica y se presenta generalmente como enfermedad metastásica.



PRESENTACIÓN DEL CASO

- Paciente femenina de 64 años con antecedentes de sleeve gástrico, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA) y obesidad grado I.
- Consultó por cuadro clínico de cuatro días de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal y ausencia de deposiciones.
- La **radiografía simple de abdomen** mostró signos de obstrucción intestinal. La **tomografía contrastada** reveló una zona de transición a nivel de la válvula ileocecal, engrosamiento parietal de 12 mm, cambios inflamatorios apendiculares.
- Se realizó **laparoscopía exploratoria**, identificando volvulación con intususcepción de la válvula ileocecal.
- Tras imposibilidad de desvolvulación, se realiza hemicolectomía derecha con anastomosis íleo-cólica latero-lateral.
- El análisis histopatológico confirmó el diagnóstico de t**umor neuroendocrino bien diferenciado** que comprometió válvula ileocecal, ciego, base apendicular y extensión ganglionar.



PRESENTACIÓN DEL CASO







Figura N°1: A. TAC corte coronal, zona de transición, volvulación, dilatación de asas distales B. Corte axial zona de transicion

CONCLUSIONES

- El presente caso clínico pone de manifiesto una forma de presentación atípica de neoplasia neuroendocrina bien diferenciada, manifestada como obstrucción intestinal secundaria a intususcepción ileocecal.
- A pesar del bajo grado histológico (G1) del tumor, el hallazgo de compromiso ganglionar y extensión extraganglionar sugiere un estadio clínico más avanzado, con implicaciones pronósticas relevantes.
- La intervención quirúrgica temprana mediante hemicolectomía laparoscópica permitió no solo la resolución del cuadro obstructivo, sino también la obtención de márgenes oncológicos adecuados, lo cual constituye el estándar terapéutico en este tipo de tumores.



RECONOCIMIENTOS



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

LA ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA

Certifica que:

El resumen titulado: "**Obstrucción intestinal intususcepción y volvulacion axial del mesocolon secundario a tumor neuroendocrino de la válvula ileocecal**", de autoría de: "**jorge eduardo peñaloza wandurraga**; Dayra Stephany Muñoz Huertas", fue admitido y presentado para el congreso.





Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Anestesiología, ginecología y salas de cirugia









Jessica Peña - UPTC
“Jessi” en salas

Guía rápida

Farmacología en

Salas de Cirugía



Hospital Regional de Monclova E.S.E.
Creciendo para cuidar tu Salud!

Propofol

ANESTÉSICOS

Agente **sedante - hipnótico.** Produce depresión global del SNC al unirse a los receptores GABA-A y potenciar los efectos del neurotransmisor GABA

Farmacocinética

- Inicio de acción: 15-60 segundos
- Duración de acción: 5-10 minutos
- Metabolismo hepático, eliminación renal.

Efectos secundarios

- > 10%: hipotensión, apnea, ardor en sitio de inyección.
- 1-10% acidosis respiratoria, hipertrigliceridemia, bradicardia, arritmias, erupción cutánea, anafilaxia.

10 mg/ml



INDICACIÓN	DOSIS
Inducción anestésica	• > 55 años, ASA > III, 1-1.5 mg/kg • Adulto < 55 años: 1.5 – 2.5 mg/kg • Niños: 2-3.5 mg/kg
Mantenimiento de anestesia	• Perfusión: 0.05-0.2 mg/kg/min, bolo intermitente de 25-50 mg.
Sedación	• Adultos: 0.25 – 1 mg/kg, bolo, titular en dosis respuesta. • Perfusión: 0.05 - 0.07 mg/kg/min; máximo 4 mg/kg/h
NVPO	• Bolo 10-20 mg (Nausea y vómito POP)
Prurito	• Bolo 10 mg (Por opiode intratecal)

No administrar > 4 mg/kg/h en perfusión, por riesgo de síndrome de infusión de propofol: falla multiorgánica, acidosis metabólica severa y rabdomiólisis

Mezclas

ANESTÉSICOS





Fármaco	Forma de preparación y concentración.
Remifentanilo	En una bolsa de solución salina normal (SSN) al 0.9% de 250 mL, se extraen 2 mL. Posteriormente, se reconstituye el vial de remifentanilo 2 mg (polvo liofilizado) con los 2 mL de SSN al 0.9%. Una vez disuelto completamente, se transfiere todo el contenido del vial reconstituido a la bolsa de SSN, de modo que el volumen final total se mantiene en 250 mL. → La concentración final de la mezcla es de 8 µg/mL (0.008 mg/mL).
Fentanilo	En una bolsa de solución salina normal (SSN) al 0.9% de 250 mL, se extraen y desechan 5 mL del contenido. Luego, se agregan 5 mL de fentanilo con una concentración de 50 µg/mL (equivalente a un total de 250 µg de fentanilo). De esta manera, el volumen final total de la bolsa permanece en 250 mL, y la concentración final de la mezcla es de 1 µg/mL.
Lidocaína	En una bolsa de solución salina normal (SSN) al 0.9% de 100 mL, se extraen y desechan 10 mL del contenido. A continuación, se agregan 10 mL de lidocaína al 2% (equivalente a 20 mg/mL × 10 mL = 200 mg de lidocaína). El volumen final de la bolsa se mantiene en 100 mL, y la concentración final de la mezcla es de 2 mg/mL.

CONTENIDO

- Propofol, ketamina, dexmedetomidina, midazolam, fentanilo, remifentanilo
- Ondansetrón, dexametasona, metoclopramida
- Rocuronio, cisatracurio, succinilcolina
- Atropina, noreprinefrina, epinefrina, etilefrina, vasopresina, dobutamina, dopamina
- Paracetamol, diclofenaco, ketorolaco, dipirona, tramadol, morfina, hidromorfona, nefopam.
- Lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína.
- Mezclas.

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL

ABORDAJE DIAGNÓSTICO

Paciente con cualquier sangrado de origen uterino con alteración el volumen, duración, frecuencia o regularidad, en ausencia de embarazo.

Historia clínica completa que incluya

1 Caracterización de sangrado menstrual e identificación de sangrado menstrual abundante

PARÁMETRO	NORMAL	ANORMAL
Frecuencia	24-38 días	Ausente: amenorrea Infrecuente: > 38 días Frecuente: <24 días
Duración	4 5 - 8 días	Prolongada: > 8 días Corta: <4 5 días
Regularidad	Regular: entre ciclo más corto y más largo, variación ≤ 9 días	Irregular: variación entre ciclos ≥ 10 días
Volumen	5-80 ml	Abundante: > 80 ml
Sangrado intermenstrual (entre menstruaciones cíclicas)	Ausente	Presente

Cuestionario SAMANTA

	Puntuación Sí	Puntuación No
1. ¿Sangra durante más de 7 días al mes?	3	0
2. ¿Tiene 2 o más días de sangrado más abundante durante su menstruación?	1	0
3. En general, ¿su regla le resulta especialmente molesta debido a su abundancia?	3	0
4. ¿En alguno de los días de sangrado más abundante mancha la ropa por las noches; o la mancharía si no usara doble protección o se cambiase durante la noche?	1	0
5. ¿Durante los días de sangrado más abundante le preocupa manchar al asiento de su silla, sofá, etc.?	1	0
6. En general, ¿en los días de sangrado más abundante, evita (en la medida de lo posible) algunas actividades, viajes o planes de ocio porque debe cambiarse frecuentemente el tampón o la compresa?	1	0

Puntuación total: Un valor ≥ 3 indica que la mujer puede tener sangrado menstrual abundante

2 Identificación de **cronología** del cuadro y síntomas asociados, antecedentes con énfasis en gineco-obstetricos, examen físico sistémico con realización de **tacto vaginal y especuloscopia**

Cribado de Trastornos de la Hemostasia

- Sangrado menstrual abundante desde la menarquia
- Uno de los siguientes condiciones
  - Hemorragia posparto
  - Sangrado relacionado con cirugía
  - Sangrado ocasionado por procedimientos dentales
- Dos o más de los siguientes
  - Moretones uno o dos veces al mes
  - Epistaxis, uno o dos veces al mes
  - Sangrado frecuente de encías
  - Antecedentes familiares de síntomas de sangrado.

Identificar Etiología



3 Solicitud de paraclínicos e imagenes como ayuda diagnóstica, para definir tratamiento e identificar etiología

Estudios iniciales "tomar a todas"	• Hemograma completo • Prueba de embarazo en mujeres en edad fértil • Tiempos de coagulación (descartar desorden de hemostasia)
Según sospecha por cribado o estudios iniciales	• Fibrinógeno • Antígeno factor Von Willebrand • Factor VII
Otros	• Función hepática, TSH
Estadio de anemia	• Ferritina, hierro sérico, saturación de transferrina
Origen incierto de sangrado	• Uroanálisis • Sangre oculta en heces

Imagenes

Su realización no es obligatoria para definir el manejo inicial. Solicitar de acuerdo a necesidad o sospecha en el paciente.

1. **Ecografía transvaginal**
2. **Sonohisterografía**
3. **Histeroscopia / biopsia de endometrio:** siempre en >45 años por riesgo de malignidad y <45 años con factores de riesgo:
   - IMC >30, Disfunción ovulatoria crónica, Exposición a estrógenos sin oposición (obesidad, SOP), Uso de tamoxifeno, Falla de tratamiento médico para HUA o HUA persistente, Síndrome de Lynch

PROTOCOLO CLÍNICO: ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Jessica Alexandra Peña Sharon Katherine Acuña R.	Médico Interno Ginecología Líder Ginecología y Obstetricia	25/09/25
VALIDÓ	Leidy Yibeth Toledo Rojas	Referente GPC y Protocolos	10/10/25
APROBÓ	Karin Milena Gamba F.	Subgerente científico	21/10/25

PROTOCOLO CLÍNICO HUA



HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL

ABORDAJE TERAPEUTICO

Se enfoca de acuerdo a cronología y estabilidad hemodinámica de la paciente.

Agudo y/o Inestable

Estabilización inicial: asegurar vía aérea, asegurar accesos venosos G18, reanimación hídrica con bolos de cristaloides 500 cc y repetir según necesidad, evaluar requerimiento de transfusión según nivel de hemoglobina.

Evaluación de respuesta cada 5 minutos con meta PAM > 65, PAS > 90, GU >0.5ml/kg/h, Hemoglobina >7 g/dl en población general o > 8 g/dl en coronariopatías.

Tratamiento Hormonal

GRADO DE ANEMIA	MANEJO	POSOLOGÍA
Severa (Hb < 7 g/dL)	Transfusión de hemoderivados → hasta lograr un HTO mayor a 30 %.	
	Dosis alta de estrógenos (Terapia opcional): Anticonceptivos con 30 mcg de Etinilestradiol y levonorgestrel 3 mg (o cualquier otro con 30 mcg)	4 mg cada 6 horas hasta que cese el sangrado, seguido de 2 mg cada 6 horas durante 2 días, luego cada 8 horas por 2 días, luego se disminuye cada 12 horas por 2 días más hasta continuar una dosis al día. Se debe agregar un progestágeno durante 10-14 días para estabilizar el endometrio estimulado.
	Acetato de noretisterona	5 - 10 mg VO cada 8 horas durante 4 días, luego cada 8 horas durante 3 días y luego cada 12 horas durante 2 semanas, para terminar única dosis diaria ó; 10-20 mg VO cada 8 - 8 horas durante una semana seguido de 10 -20 mg cada 12 h por una semana y luego única dosis diaria.
	Acetato de medroxiprogesterona	10 mg cada 4 hs vía oral (máx 80 mg) hasta el cese del sangrado, luego cada 6 h por 4 días, luego cada 8 hs por 3 días, luego cada 12 hs por 2 días hasta por dos semanas. Luego uno por día
Moderado (Hb 10 - 8 mg/dL)	Anticonceptivos orales combinados	Monofásico 30-35 mcg de etinilestradiol cada 6 horas durante 2 días, seguido de una pastilla cada 8 horas durante 48 horas. Luego continuar una pastilla cada 12 horas durante 2 días más y se continúa con una pastilla al día. Si el sangrado se reanuda a medida que se reduce la dosis, se pueden tomar 2 veces al día hasta completar 21 días.
Leve (Hb 12 – 10 mg/dL)	Anticonceptivos orales combinados	Monofásico con 30-35 mcg etinilestradiol cada 8 horas por 7 días, luego 1 día por 3 semanas

Manejo Quirurgico

Elección según paridad satisfecha y dependiendo de la causa, en consenso con ginecología se buscará la mejor opción para la paciente
ULTIMA ALTERNATIVA

- Miomectomia
- Polipectomia
- Ablación endometrial
- Legrado
- Histerectomia
- Embolización de arterias uterinas



Tratamiento NO Hormonal

Ante cualquier escenario de HUA, crónica o aguda, se debe definir la necesidad de metodos de tratamiento no hormonal:

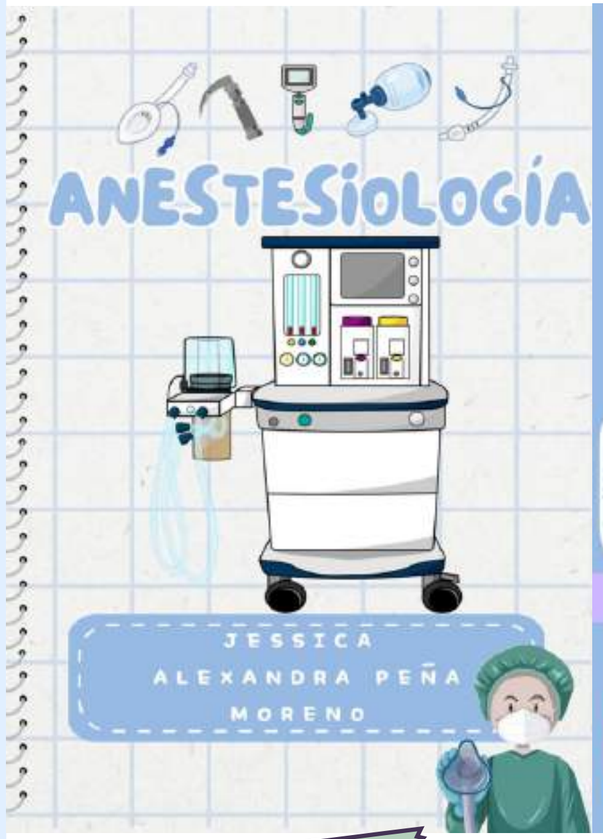
- **AINES:** Ibuprofeno 400 mg cada 8, Ácido mefenámico 500 mg/día, Naproxeno 500 mg cada 12 h
- **Ácido tranexámico:** 1 gr VO o IV cada 8 h
- **Sales de hierro** en caso de anemia sin criterio transfusional, previa realización de perfil ferrocinético (hierro sérico, ferritina, saturación de transferrina, transferrina + hemograma completo y reticulocitos si es posible)

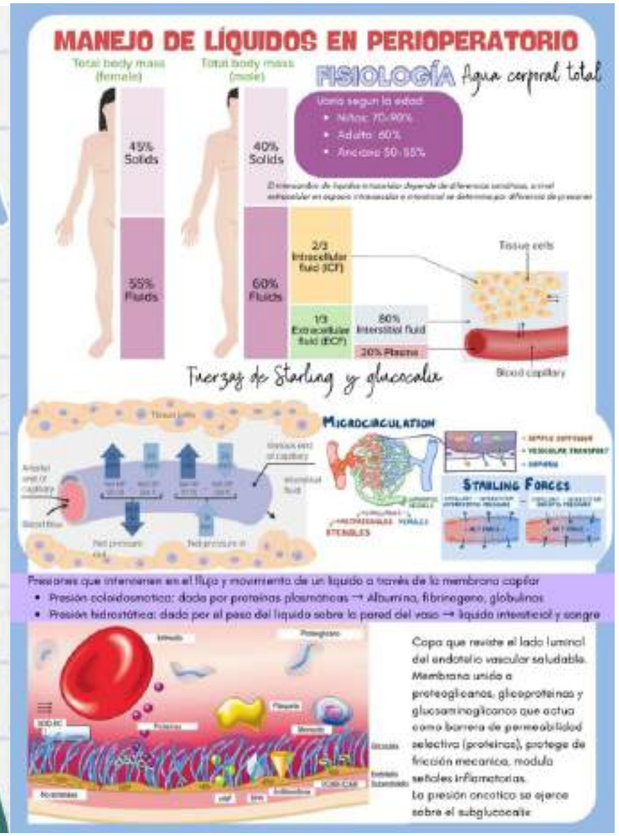
Crónica ≥ 6 meses

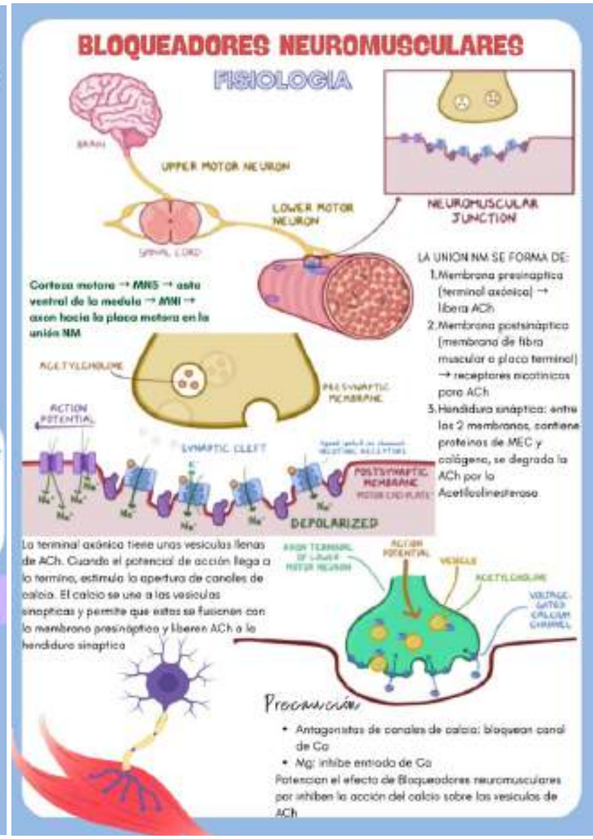
Agotar medidas farmacológicas antes de decidir manejo quirurgico

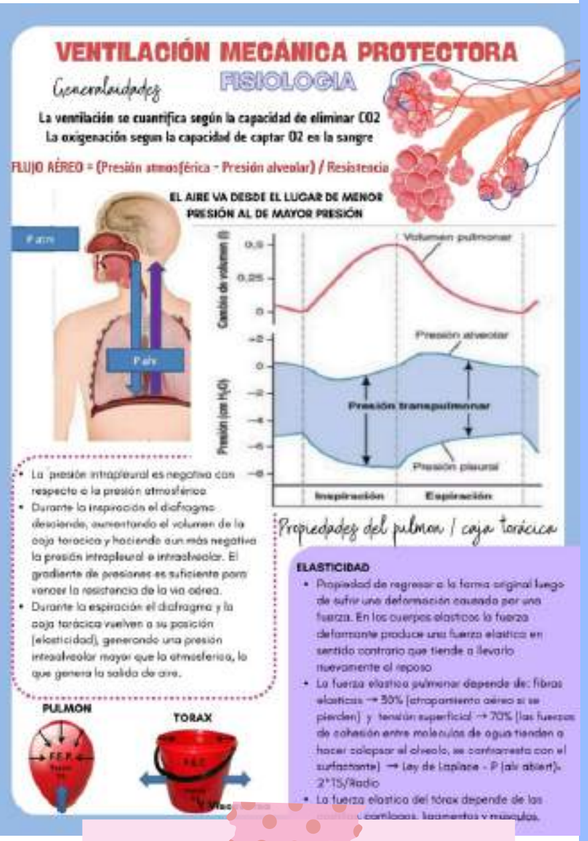
Tratamiento Hormonal

OPCIÓN TERAPÉUTICA	FÁRMACO/DOSIS
DIU-LNG Primera línea*	DIU-LNG 52 mg inserción cada 5 años, con liberación 20 mcg/día El DIU-LNG es el tratamiento de primera línea para el SMA en mujeres sin patología evidente, con miomas menores a 3 cm y sin distorsión de la cavidad uterina o con sospecha o diagnóstico de adenomiosis
ACOS Segunda línea*	Etinilestradiol 30-35 mcg/día se puede utilizar en forma cíclica, rango extendido o continuo - Cíclico: 21 días en tratamiento y 7 días libre → sangrado por deprivación, esquema clásico - Extendido: Ingesta de píldoras por 3 meses aproximadamente, y descanso de 7 días → RAM spotting - Continuo: en sangrado activo abundante, no hay interrupción de manejo Parche transdérmico, anillo Vaginal
Progesterona oral Tercera línea*	Noretisterona (NETA): 5 mg 1–3 veces/día; más potente en supresión endometrial. Medroxiprogesterona (AMP): 5–30 mg/día Se utilizan así: • Con disfunción ovulatoria: durante 10 días al mes (Fase lútea). • Sin disfunción ovulatoria: 1 comp/día del día 5 al 26 del ciclo o uso continuo ó Desogestrel diario 150 mcg/día, progestágeno de 2ª generación.
Análogo de GnRH	Acetato de leuprolide 3.75 mg mensual o 11.25mg trimestral IM









- Valoración preanestésica
- ITO difícil - DAS 2025
- Secuencia de intubación rápida
- Dispositivos de vía aérea
- Broncoespasmo
- Laringoespasmo
- RCP
- NVPO

- Anestésicos locales
- Vasopresores e inotrópicos
- Bloqueadores neuromusculares
- Opiodes
- Anestésicos endovenosos

- Dolor - generalidades y fisiología
- Síndrome doloroso regional complejo
- Fibromialgia
- Principios de ecografía
- Accesos vasculares por ecografía
- Bloqueo regional ecoguiado

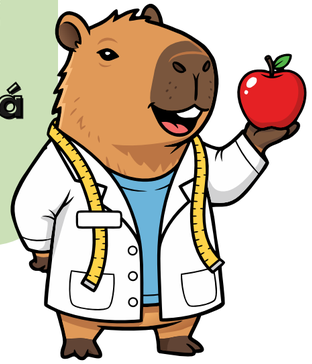
- Shock
- Lectura de gases arteriales
- Arritmias- mecanismo de generación
- Ventilación mecánica protectora
- Manejo de LEV en perioperatorio

Pediatría: tamizaje, evaluación integral y detección temprana

Ana Sofía Pineda
Angie Melissa Ruiz

Universidad de Boyacá

Pediatría - Junio



Junior Montesino - UPTC
Laura Oliveros - EIA

Pediatría - Julio y Agosto



Karent Rivera - Universidad de Boyacá
Andres Contreras y Paola Obando - Universidad de Pamplona

Pediatría - Septiembre y Octubre

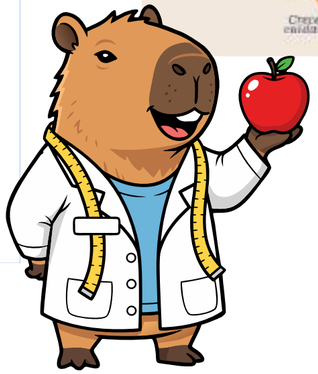


Acciones ruta integral

Calendario de Atencion integral en primera infancia, infancia y adolescencia

- Herramienta diseñada para que médicos, especialistas y personal de salud orienten mejor la consulta pediátrica.
- Facilita recordar cuándo y qué intervenciones debe recibir cada niño según su edad.
- Busca estandarizar la atención y mejorar la calidad del cuidado de madres, niños y adolescentes.





Ana Sofía Pineda
Angie Melisa Ruiz

Universidad de Boyacá
Pediatría - Junio

Contenidos principales del calendario

- **Controles de crecimiento y desarrollo por edad.**
- **Esquemas de vacunación actualizados.**
- **Valoraciones del desarrollo (EAD-3, M-CHAT, hitos motores, lenguaje).**
- **Tamizajes: anemia, visual, auditivo, salud bucal.**
- **Intervenciones clave: nutrición, desparasitación, micronutrientes, lactancia.**



PRIMERA INFANCIA
Verificar tamizaje neonatal o realizar los primeros 3 meses de vida
Promoción y apoyo de la lactancia materna
Desparasitación: 1. Niños 12-23 meses: albendazol 200 mg vía oral, dosis única, dos veces al año (junto con la suplementación). 2. Niños 24 meses a 4 años: albendazol 400 mg vía oral, dosis única, dos veces al año (junto con la suplementación).
Suplementación: hierro 1 mg al día • Antecedentes de la madre
Fortificación casera con micronutrientes en polvo entre los 6 y 23 meses con un ciclo cada 6 meses
Hierro y vitamina A: • Hierro en forma de fumarato ferroso 3 mg/kg/día dos veces al año • Vitamina A: 200.000 UI en una sola toma 2 veces al año.
Tamizaje: displasia de la cadera en desarrollo • Radiografía comparativa de caderas: todo niño a los 4 meses

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO - 3

VALORACIÓN DEL DESARROLLO

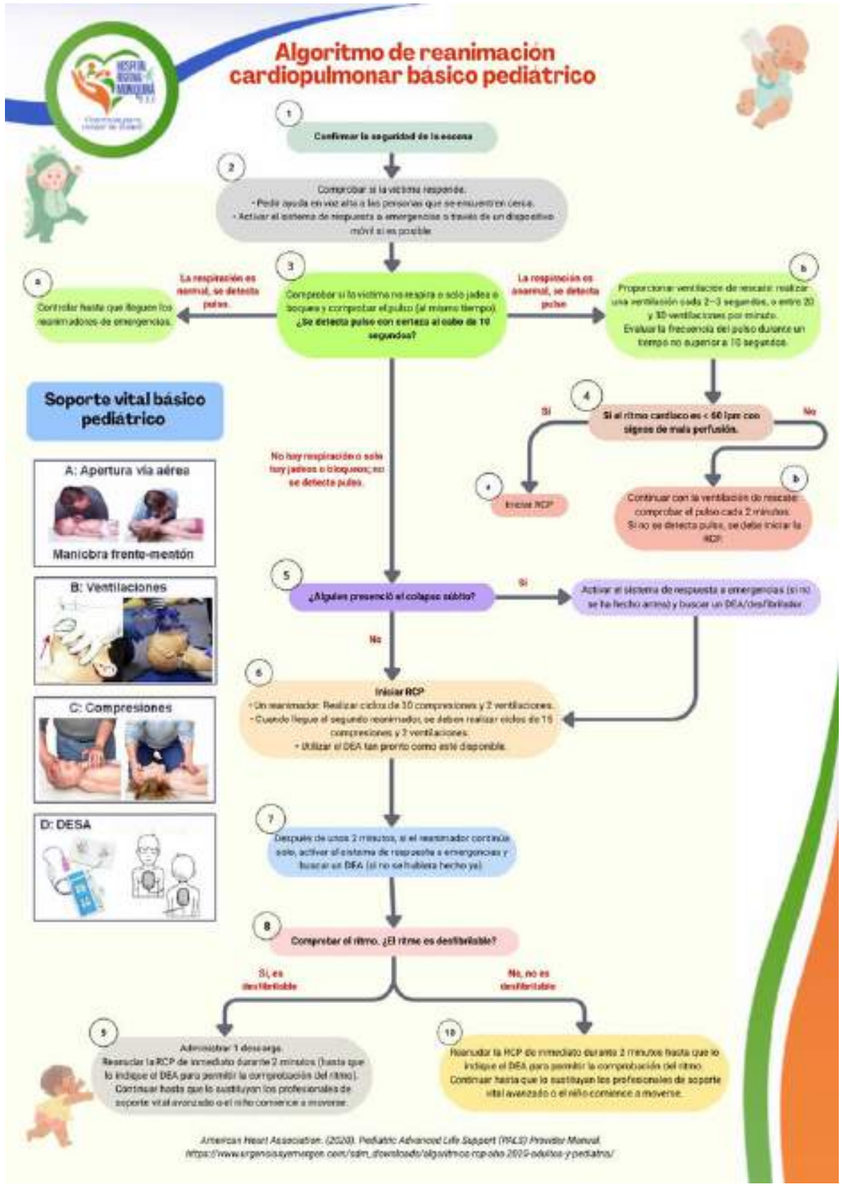
	RANGO DE EDAD
1	0 días a 1 mes 0 días
2	1 mes y 1 día a 3 meses y 0 días
3	3 meses y 1 día a 6 meses y 0 días
4	6 meses y 1 día a 9 meses y 0 días
5	9 meses y 1 día a 12 meses y 0 días
6	12 meses y 1 día a 18 meses y 0 días
7	18 meses y 1 día a 24 meses y 0 días
8	2 a 3 años (24 meses y 1 día a 36 meses y 0 días)
9	3 a 4 años (36 meses y 1 día a 48 meses y 0 días)
10	4 a 5 años (48 meses y 1 día a 60 meses y 0 días)
11	5 a 6 años (60 meses y 1 día a 72 meses y 0 días)
12	6 a 7 años (72 meses y 1 día a 84 meses y 0 días)





Pediatría: urgencias y reanimación

Algoritmo reanimación pediátrica



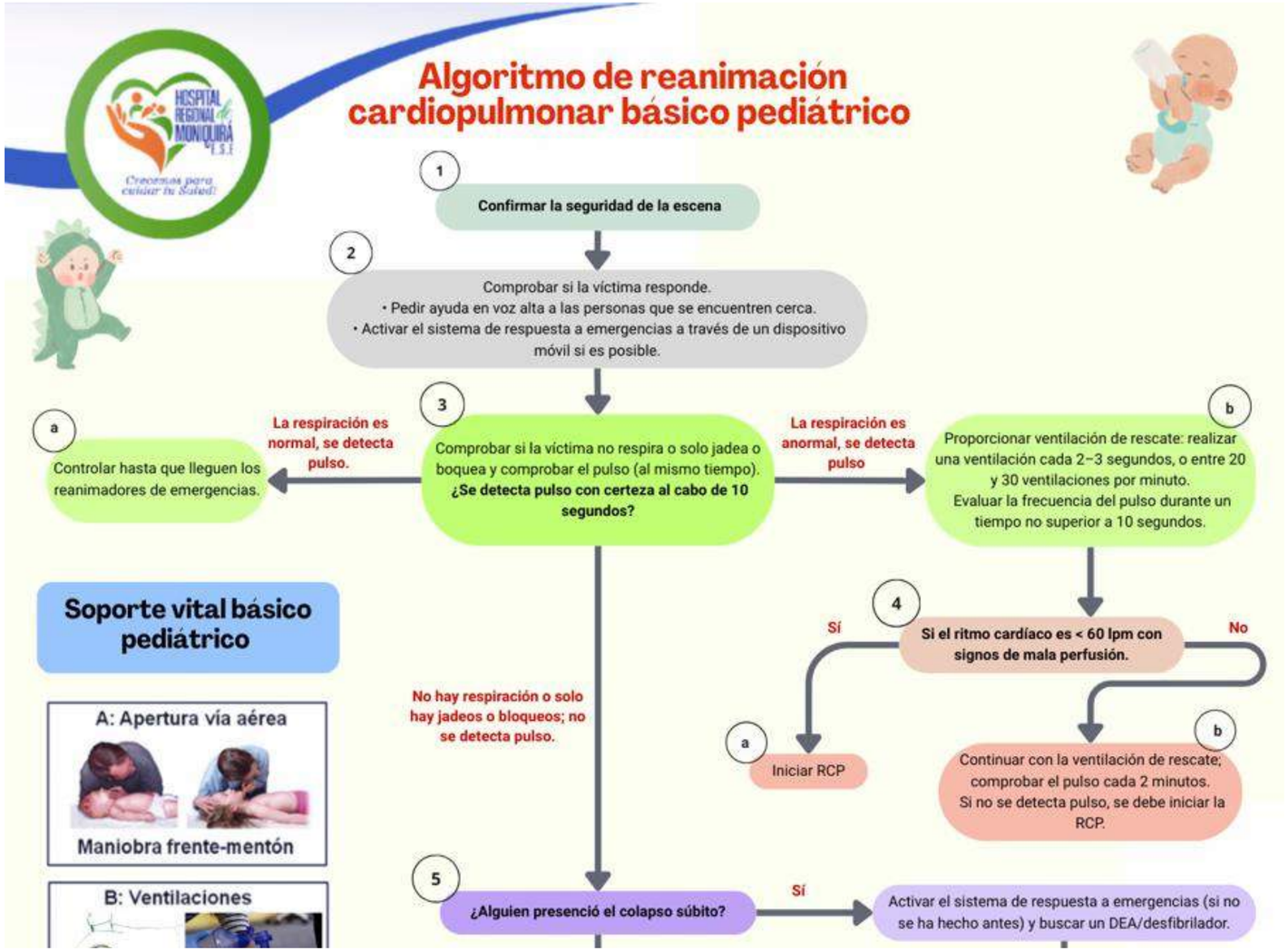
Karent Rivera - Universidad de Boyacá
Andres Contreras y Paola Obando - Universidad de Pamplona

Pediatría - Septiembre y Octubre



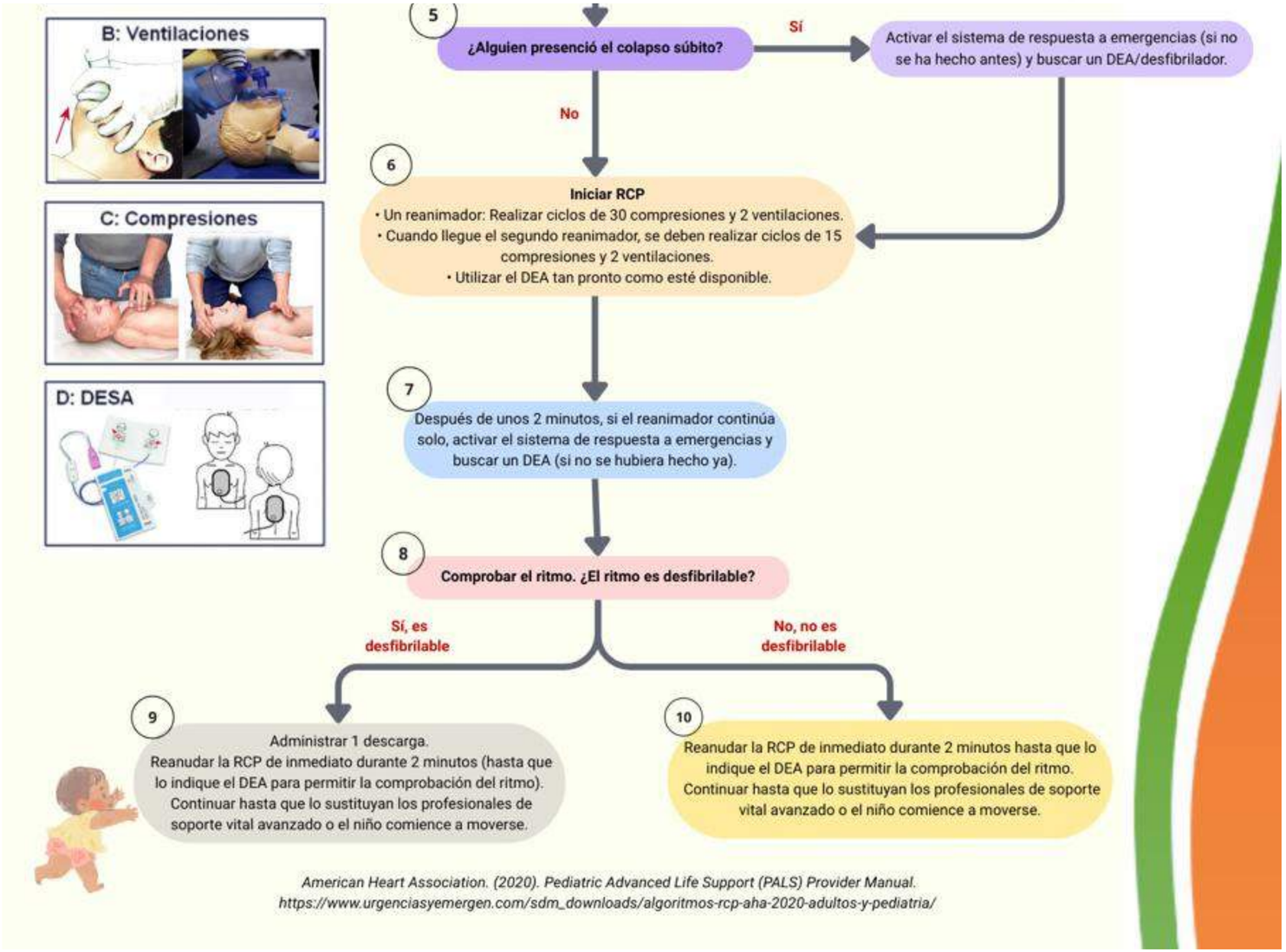
Pediatría: urgencias y manejo inicial

Algoritmo reanimación pediátrica



Pediatría: urgencias y manejo inicial

Algoritmo reanimación pediátrica



American Heart Association. (2020). Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Manual.
https://www.urgenciasyemergen.com/sdm_downloads/algoritmos-rcp-aha-2020-adultos-y-pediatria/





Tamizaje neonatal:

Detección temprana y cuidado integral del recien nacido





Junior Montesino - UPTC
Laura Oliveros - EIA

Pediatría - Julio y Agosto

Tamizaje neonatal:

Detección temprana y cuidado integral del recien nacido

1. TSH neonatal

Fecha	Resultado	Normal	Anormal	Observaciones
DD/MM/AAAA				

2. Tamizaje visual

Fecha	Reflejo rojo		Examen externo	Observacion
	Presente	Ausente		
DD/MM/AAAA				

3. Tamizaje cardíaco

Fecha	Saturación de oxígeno (SpO2)		Normal	Anormal
	Preductal	Postductal		
DD/MM/AAAA				

4. Tamizaje metabólico

Fecha	Resultado		Observaciones
	Normal	Anormal	
DD/MM/AAAA			

5. Tamizaje auditivo

Primera consulta

Examen	Emisiones		Potenciales	
	Pasó	No pasó	Pasó	No pasó
Oído derecho				
Oído izquierdo				
Recomendaciones				

Fecha: DD/MM/AAAA

Control

Examen	Emisiones		Potenciales	
	Pasó	No pasó	Pasó	No pasó
Oído derecho				
Oído izquierdo				
Recomendaciones				

Fecha: DD/MM/AAAA

Realizado por: Junior Montesino Sandoval
Médico Interno UPTC
Hospital Regional de Moniquirá



Junior Montesino - UPTC
Laura Oliveros - EIA

Pediatría - Julio y Agosto

Tamizaje neonatal:

Detección temprana y cuidado integral del recien nacido

Recomendaciones

- Coloca siempre al bebé boca arriba para dormir y sin gorros.
- Usa un colchón firme, sin almohadas, peluches ni mantas sueltas.
- Comparte la habitación, no la cama (al menos durante los primeros 6 meses).
- Baños de sol: exponer al recien nacido al sol a las 8 AM o 4 PM



Alimentación:

- Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses (si es posible).
- Alimenta a demanda: cuando el bebé lo pida, sin horarios estrictos.
- Asegúrate de que moja al menos 6 pañales al día después del 5° dia de vida.



Higiene:

- El cordón umbilical debe mantenerse limpio y seco hasta que se caiga.
- Cambiar pañales con frecuencia y limpiar bien la zona genital con pañitos humedos (sin alcohol)



Control del ambiente:

- Mantén al bebé abrigado, pero no en exceso.
- Evita exponerlo a personas enfermas o ambientes con humo de tabaco.
- Controla la temperatura de la habitación (ideal entre 20-22 °C).



Signos de alarma

Si notas alguno de estos signos, acude al médico o al servicio de urgencias inmediatamente:

- Fiebre o hipotermia
- Temperatura ≥ 38 °C o < 36 °C (en menores de 3 meses, siempre es una urgencia).
- Respiración muy rápida o muy lenta.
- Hundimiento del pecho al respirar.
- Ruidos extraños (gruñidos, silbidos).
- Coloración azulada en labios o cara (cianosis).

Problemas de alimentación

- No quiere comer o toma menos de lo habitual.
- Vomita con fuerza (en proyectil).
- Tiene dificultad para succionar o se cansa fácilmente al comer.

Letargo o irritabilidad

- Muy somnoliento, no se despierta para comer.
- Llora sin consuelo o está excesivamente irritable.

Cambios en la orina o heces

- No moja pañales por más de 6-8 horas.
- Heces con sangre, blancas o muy pálidas.
- Diarrea persistente o vómitos frecuentes.

Ictericia progresiva

- Color amarillo en la piel u ojos que aparece después del 3er día y se extiende o empeora.

Si presenta alguno de estos sintomas o signos consultar a urgencias



Junior Montesino - UPTC
Laura Oliveros - EIA

Pediatría - Julio y Agosto

Tamizaje neonatal:

Detección temprana y cuidado integral del recien nacido



Junior Montesino - UPTC
Laura Oliveros - EIA

Pediatría - Julio y Agosto



**Foto autorizada para su publicación

Medicina Familiar: prevención y manejo protocolizado

Algortimo de diagnóstico y manejo del dengue



Junior Montesino - UPTC

Medicina Familiar - Noviembre

CONEXIÓN CLÍNICA

Crecemos en Saber

Dengue

¿QUÉ ES?

1. Enfermedad viral febril aguda transmitida principalmente por la picadura del mosquito infectado *Aedes aegypti*
2. Presenta un espectro de manifestaciones que abarca desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos.
3. La **OMS** clasifica el dengue en 3 grupos, según el cuadro clínico del caso.

GRUPOS

- Dengue SIN signos de alarma — A
- Dengue CON signos de alarma — B
- Dengue grave — C
  - Síndrome de choque por dengue (SCD)

DIAGNÓSTICO

Se considera CASO PROBABLE en pacientes de área endémica que cumple criterios de:

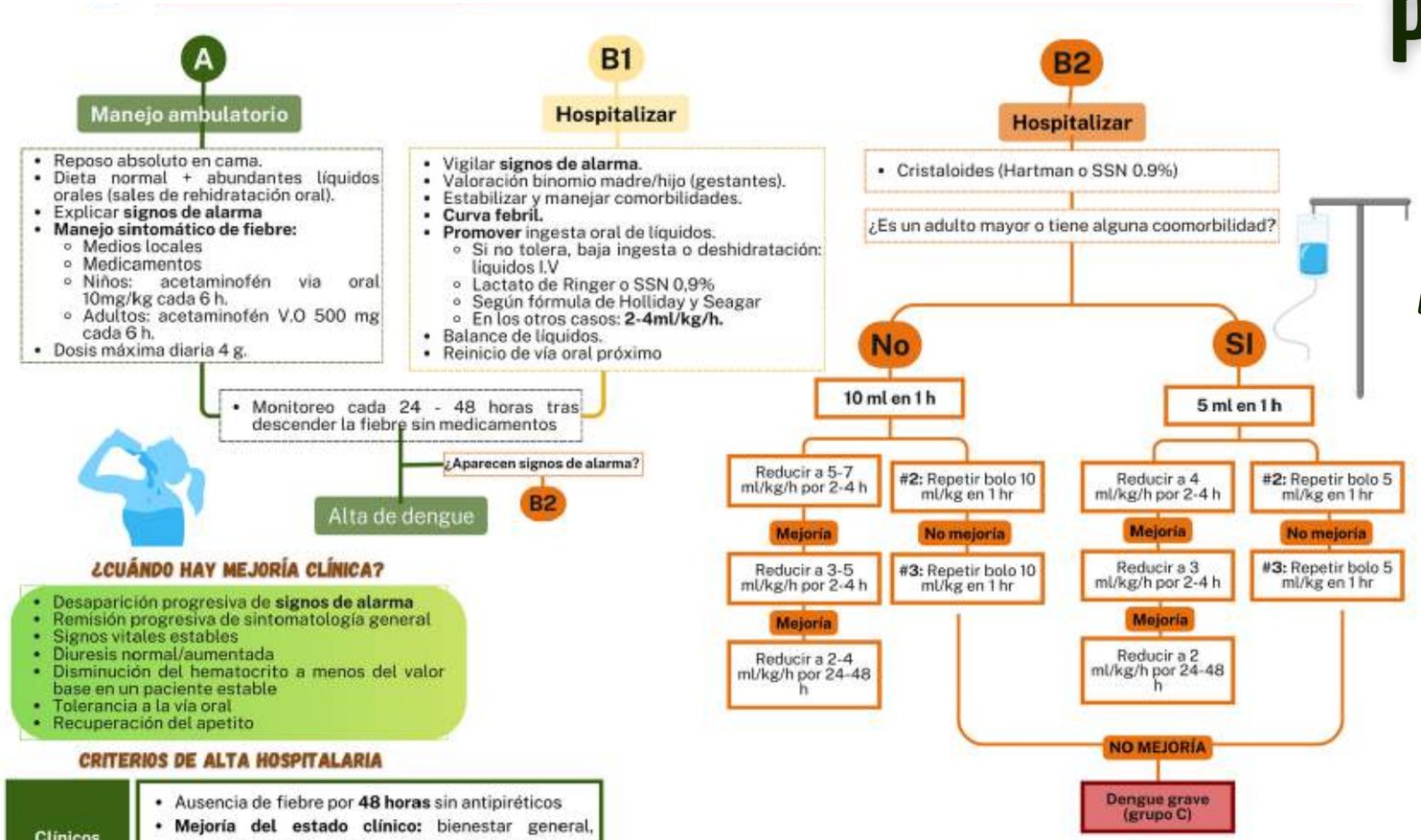
Dengue SIN signos de alarma	Dengue CON signos de alarma	Dengue grave
Enfermedad febril aguda de 2 - 7 días de evolución, con ≥2 de las siguientes manifestaciones: • Cefalea • Dolor retro ocular • Mialgias • Artralgias • Erupción cutánea, rash • Leucopenia.	Criterios de **dengue sin signos de alarma** con cualquiera de los siguientes: • Dolor abdominal intenso y continuo o a la palpación • Vómitos persistentes, • Diarrea, • Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico), • Sangrado en mucosas • Letargo o irritabilidad (niños), • Hipotensión postural, • Hepatomegalia dolorosa (>2 cm) • Caída de la temperatura, • Caída abrupta de plaquetas (<100.000) + aumento del hematocrito	Todo caso de dengue con cualquiera de las siguiente manifestaciones: • **Extravasación severa de plasma** que conduce a síndrome de choque por dengue o acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria. • **Hemorragias Severas** con compromiso hemodinámico. • **Daño grave de órganos** con signos clínicos o paraclínicos de afectación hepática, del SNC, corazón, riñón, etc.

CLASIFICACIÓN Y MANEJO

GRUPO A **Dengue sin signos de alarma**	• Tolerancia a líquidos vía oral • Sin enfermedades o condiciones asociadas • Diuresis cada 6 horas
Grupo B1 **Dengue sin signos de alarma**	• **Condiciones asociadas** • Embarazo, ≤ 1 año o ≥ 65 años, obesidad mórbida, HTA, diabetes mellitus, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, gastritis, tratamiento anticoagulante, riesgo social. • **Evaluar observación intramural**
Grupo B2 **Dengue con signos de alarma**	• Manejo intrahospilario con liquidos IV
Grupo C **Dengue Grave**	• Manejo en UCI

Medicina Familiar: prevención y manejo protocolizado

Algortimo de diagnóstico y manejo del dengue



Referencias

1. Colombia. Instituto Nacional de Salud. (2024). Protocolo de Vigilancia en Salud de Dengue (Versión 7). [Documento en línea]. Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud de Dengue. Versión 7. [Internet] 2024. https://doi.org/10.33610/JQVPR800
2. Organización Panamericana de la Salud, & Organización Mundial de la Salud. (2020). Algoritmos para el manejo clínico de los casos de dengue. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/sites/default/files/2020-09/2020-cde-algoritmos-manejo-clinico-dengue.pdf



Junior Montesino - UPTC

Medicina Familiar - Noviembre

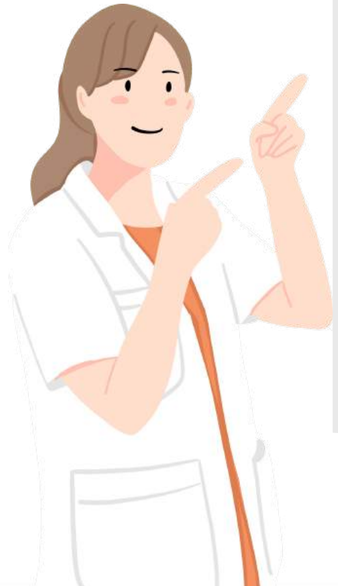
Medicina Familiar: cuidado y prevención



“Cuidando mi vida”

Cartilla para el seguimiento, educación y prevención





Dayra Muñoz - UPTC

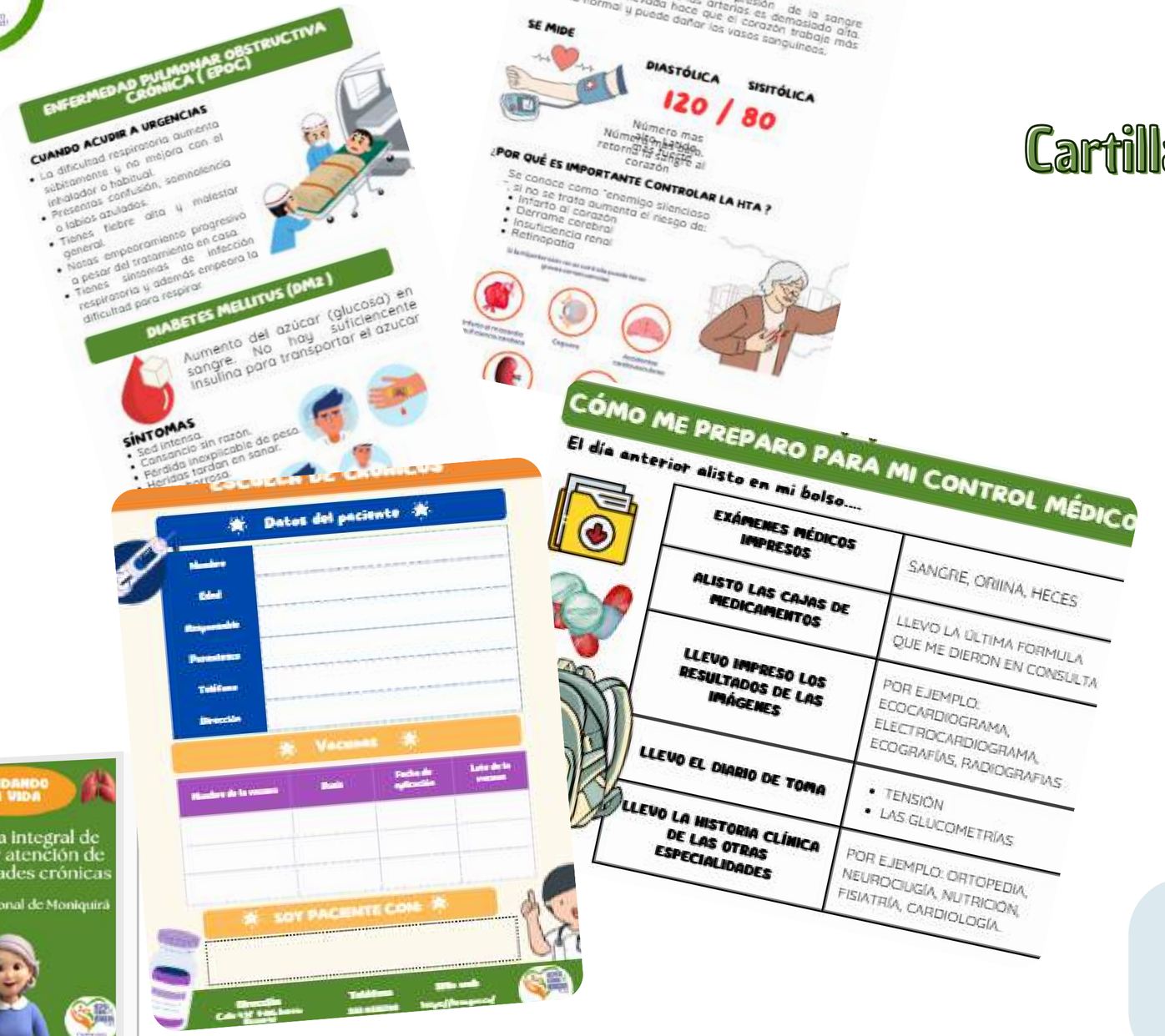
Medicina Familiar - Julio

“Cuidando mi vida”

Cartilla para el seguimiento, educación y prevención

- Cartilla individual para pacientes de la “Escuela de Crónicos” del Hospital Regional de Moniquirá
- Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, EPOC, Enfermedad Renal Crónica.
- Brinda educación, apropiación del autocuidado, tips para asistir a mis controles, metas de manejo
- Prevención y signos de alarma





Dayra Muñoz - UPTC

Medicina Familiar - Julio

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE